

عورتوں کے امراض

(عورتوں کی مخصوص بیماریوں اور علاج پر آسان کتاب)

ڈاکٹر محمد عثمان

ڈاکٹر ثمینہ عثمان



عورتوں کے امراض

(عورتوں کی مخصوص بیماریوں اور علاج پر آسان کتاب)

ڈاکٹر محمد عثمان

ڈاکٹر ثمنہ عثمان

قیمت: 120 روپے

عثمانیہ پبلی کیشنز۔ پشاور، فون: 091-2262443

صفحہ	عنوان	نمبر
04	زنانہ نظام تولید	01
11	حیض - مینسز	02
12	زنانہ بلوغت - پیورٹی	03
13	سن یاس - مینوپاز	04
14	حمل - پریگ - نینسی	05
18	طبعی وضع حمل - نارمل لیبر	06
21	حمل کی ممکنہ پیچیدگیاں	07
24	استقاط حمل - ابارشن	08
26	بے عمل حمل - ایکٹا پک - پریگ - نینسی	09
28	پرسوت کا بحار	10
29	بانجھ پن - انفرٹیلٹی	11
32	بندش حیض - اے مینوریا	12
35	دقت حیض - ڈس مینوریا	13
37	بے وقاعدہ کثرت حیض - میٹرورجیا	14
39	فیلوپین ٹیوبز کی سوزش - سالپن جوائٹس	15
41	دلوائی سوزش - دلوائیٹس	16

صفحہ	عنوان	نمبر
43	دلو کی حنا رش - پردرائی ٹس ولوائی	17
45	دیجیٹل سوزش - ویجیٹائی ٹس	18
47	سرویکس کی سوزش - سروی سائی ٹس	19
49	اینڈومیٹریٹم کی سوزش - اینڈومیٹریٹم ٹس	20
51	سیلان الرحم - لیکوریا	21
53	سوزاک - گنوریا	22
55	آئسک - سفلس	23
57	رحم کے ٹیومرز - یوٹرائن ٹیومرز	24
59	سرویکس کا کینسر - کاری نوما سرویکس	25
61	بچے دانی کا کینسر - کاری نوما یوٹروس	26
63	پستان کی سوزش - ماس ٹائی ٹس	27
65	پستان کا پھوڑا - بریسٹ ایب سس	28
67	پستان کا کینسر - کاری نوما بریسٹ	29
69	رضاعت اور پستانوں میں دودھ کی کمی	30
71	حسل کے نفسیاتی وجہ بابتی پہلو	31

زنانہ نظام تولید

(FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM)

انفرائش نسل یا نسل کو آگے بڑھانا جانداروں کی ایک بنیادی خصوصیت ہے اور اسی خصوصیت کی بناء پر جاندار اپنی نسل کو آگے بڑھانے کا یہ عمل نظام تولید کے ذریعے قائم رکھتے ہیں نسل کو آگے بڑھانے کیلئے نر اور مادہ دونوں کے نظام تولید حصہ لیتے ہیں۔ انسانوں میں نر کا نظام تولید مردوں کا نظام تولید ہوتا ہے جبکہ مادہ کا نظام تولید عورتوں کا نظام تولید ہوتا ہے۔

زنانہ نظام تولید (Female Reproductive System): عورتوں کے نظام تولید کے اعضاء کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے یعنی بیرونی اعضاء تولید اور اندرونی اعضاء تولید۔

1۔ بیرونی اعضاء تولید (External Reproductive Organs): عورتوں کے بیرونی اعضاء تولید میں مندرجہ ذیل اعضاء شامل ہیں جنکو مجموعی طور پر ولوا (Vulva) کہا جاتا ہے:

(Mons Pubis)	مونز پوبیس	◀
(Labia Majora)	لیبیا میجورا	◀
(Labia Minora)	لیبیا مینورا	◀
(Clitoris)	کلائی ٹورس	◀
(Vestibule)	ویسٹی بول	◀
(Bartholin Glands)	بارتھولین گلینڈز	◀
(Hymen)	ہائی مین یعنی پردہ بکارت	◀
(Perineum)	پیری نیم	◀

◀ **مونز پوبس (Mons Pubis):** مونز پوبس کو پیٹرو بھی کہا جاتا ہے۔ مونز پوبس دراصل زیر ناف حصہ کو کہتے ہیں اس حصہ میں جلد کے نیچے چربی اور موٹی تہہ واقع ہوتی ہے۔ بلوغت کے بعد ایسٹروجن ہارمون جو کہ اوورین پیدا کرتی ہیں کے زیر اثر مونز پوبس پر بال اگ آتے ہیں۔

◀ **لیبیا میجورا (Labia Majora):** لیبیا میجورا کو شفران کبیر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چربی کی بافتوں پر مشتمل دو بڑی شکلیں ہیں جو ولوا (Vulva) کے دونوں طرف موجود ہوتی ہیں اور یہ مونز پوبس سے شروع ہو کر پیچھے اور نگلی جانب پیری نیم میں جا کر ختم ہو جاتی ہیں۔ بلوغت کے بعد لیبیا میجورا اپنے سائز میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور صحیح طور پر نشوونما پاتے ہیں۔ بالغ ہونے پر اسکی بیرونی سطح پر بال اگ آتے ہیں۔ لیبیا میجورا کی دونوں شکلیں جلد سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں۔

◀ **لیبیا مائنورا (Labia Minora):** لیبیا مائنورا کو شفران صغیر بھی کہا جاتا ہے۔ لیبیا مائنورا چربی اور مسلر پر مشتمل دو چھوٹی چھوٹی شکلیں ہیں جو لیبیا میجورا کے اندر واقع ہوتی ہیں۔ لیبیا مائنورا کی دونوں شکلیں جلد سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ اوپر کی جانب دونوں شکلیں کلائی ٹورس کو گھیرے میں لیکر ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں جبکہ نگلی جانب یہ دونوں شکلیں ایک دوسرے میں ضم ہو کر فورچی (Fourchette) بناتی ہیں اور یہ ساخت پہلے بچے کی پیدائش کے دوران پھٹ جاتی ہیں۔

◀ **کلائی ٹورس (Clitoris):** کلائی ٹورس کو نظر بھی کہا جاتا ہے یہ ایک چھوٹا سا پر حس عضو ہے جس میں لچکدار بافتوں (Erectile Tissues) کی تہیں واقع ہوتی ہیں۔ کلائی ٹورس، مونز پوبس کے فوراً نیچے واقع ہوتا ہے اور عورت میں جنسی تحریک کے دوران اس میں تناؤ یعنی ایریکشن پیدا ہو جاتی ہے۔ عورتوں میں کلائی ٹورس مردوں میں پی نیس کے مماثل ہوتا ہے۔

◀ **ویسٹی بول (Vestibule):** ویسٹی بول کو دلیز فرج بھی کہا جاتا ہے یہ دراصل ایک مثلث نما کچنی جگہ ہے جس کے اوپر کی جانب کلائی ٹورس درمیان میں پیشاب کی نالی کا سوراخ یعنی یوریتھرا اور نیچے کی جانب ویجائنہ کا سوراخ ہوتا ہے۔ ویسٹی بول میں دو چھوٹے چھوٹے نالی نما گلینڈز بھی پائے جاتے ہیں جنہیں یوریتھرا ل گلینڈز (Urethral Glands) کہتے ہیں جو ایک خاص قسم کی رطوبت پیدا کرتے ہیں۔

◀ **بارتھولین گلینڈز (Bartholin Glands):** بارتھولین گلینڈز کو دہلیزی غدود بھی کہا جاتا ہے یہ دو گول قسم کے غدود ہوتے ہیں جو ہائی مین اور لیڈیا مائینورا کے درمیان ویسی بیول میں کھلتے ہیں جن میں سے بوقت مجامعت ایک خاص قسم کا چکنا لعاب پیدا ہوتا ہے جو کہ مرد کے پی نس کی رگڑ سے ویجائٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیتا۔

◀ **ہائی سین (Hymen):** ہائی مین کو پردہ بکارت بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ہلالی شکل کا رطوبتی جھلی پر مشتمل پردہ ہے۔ یہ ویجائٹ کے زیریں حصہ میں تنارتا ہے اور یہی پردہ دراصل اندرونی اور بیرونی اعضاء تولید کے لئے حد فاضل ہے۔ یہ پردہ انتہائی لچکدار ہوتا ہے اور دباؤ ڈالنے پر نیچے کی جانب دھنس جاتا ہے۔ ہائی مین کے سامنے والے حصے میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے تاکہ عورتوں میں ماہواری کا خون آسانی کے ساتھ خارج ہو سکے۔

◀ **پیری نیم (Perineum):** پیری نیم کو سیون بھی کہا جاتا ہے یہ وہ حصہ ہے جو ویجائٹ کے سوراخ اور مقعد کے درمیان پایا جاتا ہے اسکی لمبائی پانچ سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ پیری نیم دراصل مسلز اور فابرس ٹشوز سے ملکر بنتی ہے جس پر بال اگ آتے ہیں۔ پیری نیم وضع حمل کے وقت پھیل جاتی ہے اور بچے کی پیدائش میں قدرے آسانی پیدا کرتی ہے۔ پیری نیم اگر سخت ہو اور وضع حمل کے وقت نہ پھیل سکے تو یہ پھٹ بھی سکتی ہے اور بچے کی پیدائش میں مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔

2- **اندرونی اعضاء تولید (Internal Reproductive Organs):** عورتوں کے اندرونی اعضاء تولید میں مندرجہ ذیل اعضاء شامل ہیں:

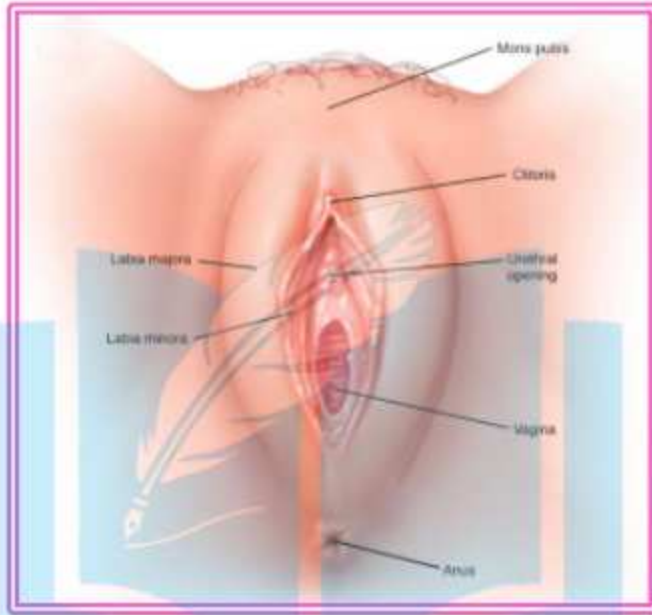
(Vagina)	ویجائٹ یعنی شرمگاہ	◀
(Uterus)	یوٹرس یعنی بچے دانی	◀
(Fallopian Tubes)	فیو پیو ٹیوبز یعنی قاذف نالیاں	◀
(Ovaries)	اووریز یعنی بیضہ دانیاں	◀

◀ **وہجائنہ (Vagina):** اندام نہانی 7.5 سینٹی میٹر لمبی ٹیوب ہے۔ اندام نہانی اندرونی اور بیرونی اعضائے تولید کو آپس میں ملاتی ہے۔ اندام نہانی میں کسی طرح کے اخراجی گلینڈز موجود نہیں ہوتے لیکن اندام نہانی سرویکس کی خارج کردہ رطوبتوں کی وجہ سے تر رہتی ہے اندام نہانی کے اوپر کی جانب کے حصے نے رحم کے نچلے حصے سروکس کو لپیٹ رکھا ہوتا ہے۔ عام طور پر اندام نہانی کی دیواریں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں۔

◀ **یوٹرس (Uterus):** یوٹرس یعنی بچہ دانی ایک موٹے مسلز کا بنا ہوا عضو ہے جو کہ پیلووس میں موجود ہوتا ہے۔ یوٹرس ریکٹم اور مثانے کے درمیان میں موجود ہوتا ہے۔ یوٹرس تقریباً 7.5 سینٹی میٹر لمبا اور اس کا وزن تقریباً ساٹھ گرام ہوتا ہے۔ یوٹرس نیچے کی جانب اندام نہانی سے ملا ہوتا ہے اور اوپر کی جانب یوٹرائن ٹیوبز سے ملا ہوتا ہے یہ یوٹرائن یا فیلوپین ٹیوبز یوٹرس کے دائیں اور بائیں جانب تعداد میں ایک ایک واقع ہوتی ہیں۔ یوٹرس کے افعال میں یہ شامل ہے کہ یہ فریٹلائزڈ اووم کو اپنے پاس رکھے اور اسے بڑھنے میں مدد دے۔ اس کے علاوہ جب اووم، اووری سے نکلتا ہے تو فیلوپین ٹیوب کے راستے یوٹرس میں آتا ہے۔ بلوغت کے بعد یوٹرس میں خاص قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں اور یوٹرس حیض جاری کرتا ہے۔ حمل کے دوران جو کہ عام طور پر چالیس ہفتے رہتا ہے یوٹرس بڑھتا رہتا ہے جب بچے کی پیدائش ہو رہی ہو تو یوٹرس آہستہ آہستہ سکڑتا ہے اور بچے کی پیدائش میں مدد دیتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد یوٹرس آہستہ آہستہ دوبارہ واپس اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ یوٹرس کے واپس اپنی اصلی حالت میں آنے کو ان والیویشن آف یوٹرس کہتے ہیں۔

◀ **فیلوپین ٹیوبز (Fallopian Tubes):** فیلوپین ٹیوبز یا یوٹرائن ٹیوبز تعداد میں دو ہوتی ہیں جو کہ یوٹرس کے دونوں جانب اوپر کے حصے میں واقع ہوتی ہیں۔ یہ یوٹرائن ٹیوبز یوٹرس کے دائیں اور بائیں جانب باہر کی طرف نکلتی ہیں۔ یہ یوٹرائن ٹیوبز تقریباً 10 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہیں۔ یوٹرائن ٹیوبز کا کام یہ ہے کہ یہ اووری سے پیدا شدہ اووم کو یوٹرس تک پہنچاتی ہیں اور اووم کو فریٹلائزیشن کے لئے جگہ مہیا کرتی ہیں۔

◀ **اووریز (Ovaries):** اووریز یا خصیتہ الرحم دو بادام نما گلینڈ ہیں جو کہ یوٹرس کے دونوں طرف تعداد میں ایک ایک موجود ہوتے ہیں۔ اووریز دونوں جانب یوٹرائن ٹیوب کے عین نیچے واقع ہوتی ہیں۔ اووریز کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے اووم ہوتے ہیں۔

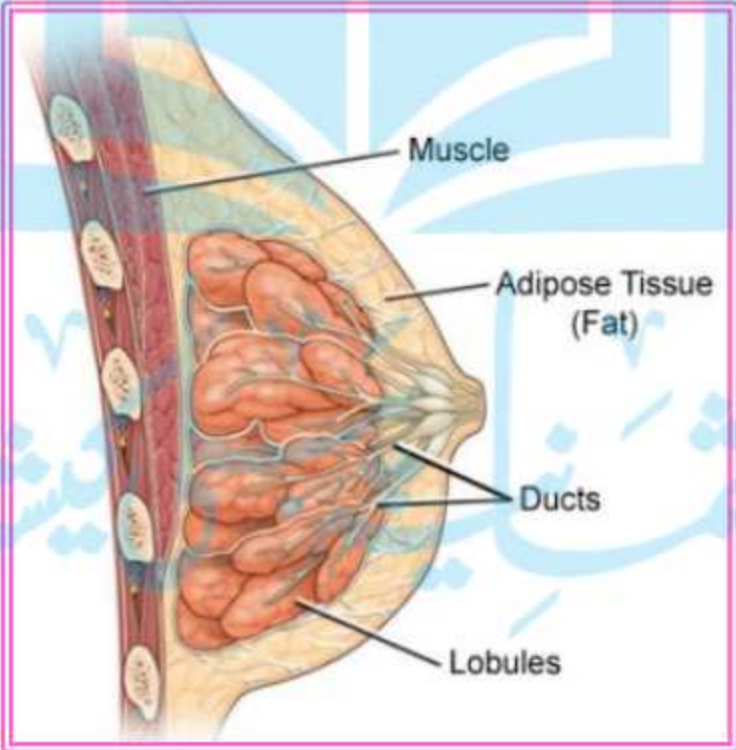


عورتوں کے بیرونی اعضاء تولید



عورتوں کے اندرونی اعضاء تولید

پستان (Breasts): پستان تعداد میں دو ہوتے ہیں اور دودھ پیدا کرتے ہیں۔ بلوغت کے دوران پستان بڑے ہو جاتے ہیں اور حمل کے دوران اپنے نارمل سائز سے بڑھ جاتے ہیں جبکہ بڑھاپے میں پستان سکڑ جاتے ہیں۔ پستان سینے پر آگے کی جانب ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پستانوں کے درمیان میں ایک ابھار سا ہوتا ہے جسے نپل کہتے ہیں یہ نپل پستان کی نسبت ذرا گہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ نپل کے ارد گرد پستانوں پر ایک دائرہ سا موجود ہوتا ہے جسے ایریولا کہتے ہیں۔ نپل کے نچلے ایریا میں خاص قسم کے گینڈز موجود ہوتے ہیں یہ گینڈز اپنی رطوبت کے ذریعے نپل کو چکنا کر رکھتے ہیں۔ نپل میں پندرہ سے لے کر بیس تک سوراخ موجود ہوتے ہیں جو کہ دراصل پستان کے دودھ کی نالیاں ہوتی ہیں۔ پستانوں کا کام یہ ہے کہ یہ دودھ بنائیں اور جب بچہ پستان کو چوسے تو پستانوں میں سے دودھ نکل کر بچے کے منہ میں جائے اور اس کی غذا بنے۔ حمل کے سولہویں ہفتے ہی سے پستانوں میں ایک خاص قسم کی رطوبت بننا شروع ہو جاتی ہے جو کہ دودھ کی نالیوں کو کھلا رکھتی ہے اور پستانوں کو اپنے افعال سرانجام دینے کیلئے تیار رکھتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد دو سے تین دن تک پستانوں سے ایک تیلی سے رطوبت آتی ہے جسے کلا سٹرم کہتے ہیں۔ یہ رطوبت پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد مکمل طور پر پستانوں سے دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پچوٹری گینڈ کے اگلے حصے کا ایک ہارمون پرو لیکٹن پستانوں میں دودھ بنانے کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ مختلف عورتوں میں پستانوں کا سائز پستانوں میں موجود لایبوز کی مقدار اور ہارمونز کی پیدائش پر منحصر ہے اگر پستانوں میں لایبوز زیادہ اور ہارمونز کی پیدائش اچھی ہوگی تو پستانوں کا سائز بھی اچھا ہوگا اور اگر پستانوں میں لایبوز کم اور ہارمونز کی پیدائش کم ہوگی تو پستان چھوٹے ہوں گے۔ اسی طرح پستانوں کی نشوونما میں اچھی غذا، اچھی صحت، عمر، اچھے ماحول اور اچھی نفسیاتی کیفیات کا بھی عمل دخل ہے۔ اچھے اور صحت مند پستان عورت کی صحت مندی کی نشانی ہیں۔ کئی مرتبہ عورتوں میں پستانوں کی بیماریاں بھی پائی جاتی ہیں جن میں پستانوں کی سوزش، پستانوں کا درد، پستانوں کا پھوڑا، پستانوں میں دودھ کی کمی، پستانوں میں دودھ کی زیادتی اور پستانوں کا کینسر وغیرہ شامل ہیں۔



عورتوں میں پستان کی وضع اور ساخت

حیض - مینسٹرز

(MENSTRUATION)

عورت جب بالغ ہوتی ہے تو اسے ہر مہینے اندام نہانی کے راستے خون کا اخراج ہوتا ہے جو کہ عام طور پر 3 سے 5 دن تک جاری رہتا ہے حیض کے دوران خارج ہونے والا خون 30 سے 40 ملی لیٹر تک ہوتا ہے اور اس خون میں جنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ حیض دراصل اینڈومیٹریئم کے افعال کا ایک چکر ہے جو کہ تقریباً 28 دن میں مکمل ہوتا ہے۔ اینڈومیٹریئم کے افعال کے اس چکر میں 7 دن کم یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لڑکیوں میں بلوغت سے پہلے حیض نہیں آیا کرتا۔ بالغ ہونے پر جب لڑکی کی بیضہ داناں اور بچے دانی اپنے افعال شروع کرتی ہے تو اسے حیض کا خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک نارمل صحت مند لڑکی میں حیض کا یہ خون ہر ماہ آیا کرتا ہے جو کہ تین سے پانچ دن تک جاری رہتا ہے۔ عام طور پر جب لڑکی کو حیض ہوتے ہیں تو اسے اپنے پیڑ، رانوں اور کمر میں معمولی قابل برداشت درد محسوس ہوتا ہے جو کہ لڑکیوں کے لئے ایک عام سی بات ہے لیکن کئی مرتبہ دورانِ حیض یہ درد انتہائی تیز ہو جاتا ہے جسے پُر درد حیض یعنی ڈسمینوریا کہتے ہیں۔ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ عام نارمل سی درد کش ادویات دینے سے حیض کا یہ درد کم ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح کئی مرتبہ لڑکیوں میں حیض کا خون انتہائی زیادہ یا بار بار آتا ہے جسے بالترتیب مینورہیجیا اور میٹروہیجیا کہا جاتا ہے جس کا ذکر آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ حمل کے دوران نو ماہ تک عورت کو حیض نہیں آتا اور اسی طرح پچاس سے پچپن سال کی عمر میں عورتوں میں حیض ختم ہو جایا کرتا ہے۔ کئی مرتبہ لڑکیوں اور عورتوں میں حیض سے متعلق کئی قسم کے نقائص پائے جاتے ہیں جن کا علاج کوئی بھی مستند لیڈی ڈاکٹر کرتی ہے۔ اس ضمن میں حیض کے نقائص کے مطابق مختلف ٹیسٹوں کے ذریعے تشخیص کر کے حیض سے متعلق بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں عورتوں کی دوسری بیماریوں کے علاوہ حیض سے متعلق بیماریوں کا بھی تفصیلاً ذکر اور علاج لکھا گیا ہے۔

زنانہ بلوغت - پیوبرٹی

(PUBERTY IN FEMALES)

زنانہ بلوغت وہ زمانہ ہے جس میں عورت کی جسمانی نشوونما اور جنسی اعضاء کی نشوونما ہوتی ہے۔ عورتوں میں زمانہ بلوغت عموماً 12 سے 14 سال کی عمر میں آتا ہے۔

زمانہ بلوغت کی وجہ (Cause of Puberty): بلوغت سے پہلے گونیڈوٹروفن یعنی لیوٹینائزنگ ہارمون اور فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمونز پچوٹری گلینڈ کے اگلے حصہ سے خارج نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن زمانہ بلوغت میں پچوٹری گلینڈ کے اگلے حصے سے یہ ہارمون خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ عورت کی اووریز پر اثر کرتے ہیں اور اووریز سے ایسٹروجنز اور پروجیسٹرون ہارمون خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسٹروجنز ہارمون کے اخراج کے زیر اثر عورتوں میں جسمانی نشوونما، جنسی نشوونما اور حیض جاری ہو جاتا ہے اور یوں عورتوں میں زمانہ بلوغت شروع ہو جاتا ہے۔

زمانہ بلوغت میں تبدیلیاں (Changes During Puberty): زمانہ بلوغت میں عورتوں میں درج ذیل جسمانی، جنسی اور نفسیاتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو کہ عورت کے بالغ ہوجانے کی علامات و نشانیاں ہیں؛

پستانوں کا بڑھ جانا، زیر ناف بالوں کا نمودار ہو جانا اور بغلوں میں بال نمودار ہو جانا۔	➤
کولہے کی ہڈیاں پھیل جانا، قد بڑک جانا، آواز میں نسوانیت آ جانا اور پہلا حیض یعنی مینارک کا ہونا۔	➤
عورتوں کی جلد چکنی، موٹی اور نرم ہو جانا، عورتوں میں شر میلہ پن اور بناؤ سنگھار کا رجحان ہو جانا۔	➤
شرمگاہ کی لیپیا میچور اکاسائز میں بڑھ جانا، یوٹرس اور ویجائنا کا سائز بڑھ جانا۔	➤
عورتوں کا ہر بات پر جلد شرمنا جانا، پرکشش و جذباتی ہو جانا، جنسی رغبت و خواہش کا بڑھ جانا وغیرہ۔	➤

سن یاس - مینوپاز

(MENOPAUSE)

سن یاس سے مراد عورتوں میں وہ زمانہ ہے جس میں افزائش نسل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور حیض مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے سن یاس کا زمانہ عموماً 50 سے 55 سال کی عمر میں آتا ہے۔

سن یاس کی وجہ (Cause of Menopause): سن یاس کے زمانے میں عورتوں میں اووریز کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں جس کی وجہ سے عورتوں کے جسم میں پروجیسٹرون ہارمون کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور فالیکل سٹیولیٹنگ ہارمون کی مقدار جسم میں زیادہ ہو جاتی ہے جس سے عورتوں کے جسم میں کئی جسمانی، جنسی اور نفسیاتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ سن یاس میں عام طور پر حیض آہستہ آہستہ رک جاتا ہے لیکن کبھی کبھی حیض ایک دم بند بھی ہو جاتا ہے۔

سن یاس کی علامات و نشانیاں (Signs / Symptoms): زمانہ سن یاس جب شروع ہوتا ہے تو عورتوں میں درج ذیل جسمانی، نفسیاتی اور جنسی تبدیلیاں آہستہ آہستہ یا پھر یکدم ظاہر ہوتی ہیں؛

حیض کا بند ہو جانا، جسم میں گرم لہریں محسوس ہونا اور گرم لہروں کے بعد پسینے آنا۔	✍
نفسیاتی تبدیلیوں کے زیر اثر ہلکا سا بلڈ پریشر بڑھنا، تشویش اور ڈپریشن و بے خوابی کا پیدا ہو جانا۔	✍
جسمانی اور اعصابی تھکاوٹ کے اثرات ظاہر ہونا، چڑچڑاپن، سردرد، چکر و نظام انہضام کا متاثر ہونا۔	✍
دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا، جوڑوں میں درد، ہڈیوں کے جھڑنے اور ٹوٹنے کا رجحان ہو جانا۔	✍
جلد کا خشک اور کھردرا ہو جانا، پستانوں، ویجائنہ، اووریز، یوٹرس اور فیلوپین ٹیوبز کا سکڑنا۔	✍
ویجائنہ کا سکڑ کر چھوٹا ہو جانا اور اس میں سوزش و خارش ہونا وغیرہ۔	✍

حمل - پریگ نینسی (PREGNANCY)

حمل عورتوں کے جسم میں ایک ایسا عمل ہے جو کہ بلوغت کے بعد کسی مرد سے جنسی تعلق قائم کرنے پر ہوتا ہے۔ حمل عام طور پر 36 سے 42 ہفتے تک قائم رہتا ہے۔

حمل کی نشانیاں / علامات (Signs / Symptoms of Pregnancy): حاملہ ہو جانے پر عورت میں مندرجہ ذیل طبعی اور نفسیاتی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن سے یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ عورت حاملہ ہے۔ عورت کے جسم میں پیدا ہونے والی یہ طبعی اور نفسیاتی تبدیلیاں حمل کی نشانیاں اور علامات ہوا کرتی ہیں۔ حمل یعنی پریگ نینسی کی یہ نشانیاں اور علامات درج ذیل ہیں:

حیض کا بند ہو جانا: حیض کی بندش حمل کی پہلی نشانی ہے لیکن بعض اوقات بندش حیض کی کوئی اور وجہ مثلاً نفسیاتی دباؤ، ٹینشن، ڈپریشن، ہارمونز کی کمی بیشی یا کوئی اندرونی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اس لئے بندش حیض ہمیشہ حمل کی یقینی علامت نہیں ہوا کرتی جب تک کہ حمل سے متعلقہ دوسری علامات کا اظہار نہ ہو۔

صبح کی متلی اور تھکن: اکثر عورتیں حمل کے دوسرے سے چھپتے ہفتے کے درمیان متلی اور قے کی شکایت کرتی ہیں، صبح بستر سے اٹھتے وقت تھکاوٹ محسوس کرتی ہیں ایسا عام طور پر تیسرے مہینے تک ہوتا ہے۔

کھٹی چیزوں کی خواہش: حاملہ عورت کے منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ کھٹی چیزیں مثلاً لیموں یا اچار کھانے کی خواہش کرتی ہے۔ بعض اوقات عورتیں حمل کے دوران مٹی اور کوئلہ بھی کھانے لگتی ہیں۔

پستانوں کا بڑھ جانا: حمل ٹھہرنے کے بعد چھاتیاں بڑھ جاتی ہیں اور ان کے اوپر کی رگیں پھول جاتی ہیں دبانے سے پستان درد کرتے ہیں بھٹنیاں بڑھ جاتی ہیں اور ان کے ارد گرد موجود حلقے کارنگ گہرا ہو جاتا ہے۔

پستانوں میں دودھ آنا: تیسرے مہینے کے بعد چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے۔

پیٹ کا بڑھنا: بچے دانی میں جنین کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ حاملہ کا پیٹ بھی بڑھتا جاتا ہے۔

جلدی تبدیلیاں: حاملہ کی جلد پر بھورے رنگ کے داغ بن جاتے ہیں یہ داغ خاص طور پر ماتھے پر، منہ، ناف کے ارد گرد اور ناف کے کولہے کے سامنے کی ہڈی کے درمیان موجود لائن پر ہوتے ہیں۔

رحم میں تبدیلی: حاملہ کا سرویکس نرم ہو جاتا ہے اور اس کا بیرونی منہ تھوڑا سا کھل جاتا ہے جس میں سے تھوڑا سا سفید مادہ نکلتا ہے۔

وجہاں: خون کی زیادتی کی وجہ سے حاملہ کی وجہاں کی رنگت بیگنی ہو جاتی ہے۔

تسب: حاملہ عورت کو اکثر قبض ہو جاتی ہے کبھی کبھی حاملہ عورت کو بواسیر کی شکایت بھی ہو جاتی ہے۔

ناٹگوں میں انزاسیاں: ساتویں مہینے میں حاملہ عورت کی ناٹگوں میں درد اور انزاسیاں پیدا ہو جاتی ہیں ایسا ناٹگوں کے اعصاب اور رگوں پر رحم کا دباؤ پڑنے سے ہوتا ہے۔

سانس لینے میں تکلیف: حمل کے آخری مہینوں میں رحم کے اوپر چڑھ جانے سے چھاتی تنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے حاملہ کو سانس لینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔

پیشاب کا بار بار آنا: پیشاب کا بار بار آنا بھی حمل کی ایک نشانی ہے۔

مندرجہ بالا تمام علامات کو سامنے رکھتے ہوئے حمل کی تشخیص کی جاسکتی ہے لیکن حمل کی یقینی تشخیص کے لئے درج ذیل علامات بھی ہوا کرتی ہیں:

◀ حاملہ کے پیٹ پر ہاتھ رکھیں تو کبھی کبھی رحم کی حرکات ہاتھ کو محسوس ہوتی ہیں۔

◀ پانچویں مہینے کے دوران ماں کے پیٹ میں بچے کی حرکات کو ہاتھ لگانے سے محسوس کیا جاسکتا ہے اور ماں کو خود بھی بچہ پیٹ میں حرکت کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

◀ حاملہ کے پیٹ پر کان، اسٹتھو سکوپ، فیٹو سکوپ لگا کر بچے کے دل کی آواز کو بھی سنا جاسکتا ہے۔

◀ یہ آواز اکثر حاملہ کے پیٹ کے بائیں طرف ناف اور چڈے کے درمیان ہوتی ہے۔

◀ بچے کے دل کی رفتار 130 سے 160 مرتبہ فی منٹ ہوتی ہے۔

◀ چھٹے مہینے میں اگر عورت کی وجہاں میں انگلی ڈال کر رحم کو اوپر کی طرف کیا جائے تو بچہ اوپر ہو کر پھر نیچے آتا

محسوس ہوتا ہے اس طریقے کو Ballotement کہتے ہیں۔

حمل کی تشخیص (Diagnosis of Pregnancy): کسی بھی عورت میں حمل کی تشخیص درج ذیل طریقوں سے کی جاسکتی ہے:

پیشاب کا پریگ ٹیسٹ (Urine for Pregnancy): حاملہ عورت کے پیشاب میں ہیومن کوریونک گوئیٹروٹروفن ہارمون موجود ہوتا ہے لہذا حاملہ عورت کے پیشاب میں اسی ہارمون کا پتہ چلایا جاتا ہے۔ پیشاب میں اگر یہ ہارمون موجود ہو تو حمل کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ پیشاب کا یہ پریگ ٹیسٹ آخری حیض ہونے کے چالیس دن کے بعد کیا جانا چاہیے۔

تشخیص بذریعہ الٹراساؤنڈ (Ultrasound): پیٹ کے الٹراساؤنڈ کے ذریعے بھی حمل ٹھہرنے کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ الٹراساؤنڈ کے ذریعے نہ صرف حمل کی تشخیص کی جاسکتی ہے بلکہ ماں کے پیٹ میں بچے کی حرکات، بچے کے سر کی پیمائش، ایک سے زائد بچوں کی موجودگی، بچے کی پوزیشن، پلے سینٹاکی پوزیشن، بچے کے دل کی دھڑکن و رفتار، بچے کی جنس اور بچے کے زندہ یا مردہ ہونے کا پتہ چلایا جاسکتا ہے۔

معائنہ بذریعہ ایکس رے (X-Ray Examination): اگرچہ حمل کی تشخیص اور دیگر حقائق معلوم کرنے کے لئے ایکس رے بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن ایکس رے کے بد اثرات کی بناء پر اس کا استعمال بتدریج کم ہو رہا ہے تاہم بسا اوقات ایکس رے کا استعمال ناگزیر ہوتا ہے۔ ایکس رے کے معائنے کے ذریعے بچے کی پوزیشن، عمر و سائز اور ایک سے زیادہ بچوں کی موجودگی کا پتہ چلایا جاسکتا ہے۔

پیٹ کا معائنہ (Abdominal Examination): حمل کی تشخیص میں حاملہ کے پیٹ کا معائنہ بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ حاملہ کے پیٹ کے معائنے کے ذریعے یوٹرس کا سائز، بچے کا سائز اور پوزیشن، بچے کے دل کی دھڑکن اور بچے کے زندہ اور مردہ ہونے کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

شرم گاہ کا معائنہ (Vaginal Examination): حمل کے دوران شرم گاہ کا معائنہ بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے، شرم گاہ کے معائنے کے دوران شرم گاہ میں ہونے والی تبدیلیوں، حمل کی مدت، یوٹرس اور سرویکس کی بے قاعدگیوں، یوٹرس کی پوزیشن کا اندازہ کرنے کے علاوہ حاملہ عورت کے پیلووس کے مختلف حصوں کی بھی پیمائش کی جاتی ہے۔

دوران حمل احتیاطیں (Precautions): دوران حمل عورت کو مقوی اور طاقت بخش غذا کھانا چاہیے۔ حاملہ عورت کو لباس آرام دہ اور ڈھیلا پہننا چاہیے۔ دوران حمل ہلکی پھلکی ورزش حاملہ کیلئے ضروری ہے۔ چہل قدمی حاملہ عورت کیلئے بہت اچھی ورزش ہے۔ حاملہ عورت کو روزانہ نیم گرم پانی سے غسل کرنا چاہیے۔ حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے ذہن کو تفکرات اور پریشانیوں سے دور رکھے۔ حاملہ عورت کو بھاری وزن اٹھانے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ حاملہ عورت کو اپنے جسمانی آرام اور نیند کا مکمل طور پر خیال کرنا چاہیے۔ حاملہ عورت کو اپنا میڈیکل چیک اپ کسی مستند لیڈی ڈاکٹر سے مستقل طور پر کراتے رہنا چاہیے۔



چالیسویں ہفتے کی حاملہ میں بچے کی پوزیشن



طبعی وضع حمل - نارمل لیبر (NORMAL LABOUR)

طبعی وضع حمل ایک ایسا قدرتی عمل ہے جس میں حمل کی مدت پوری ہونے پر بچہ پہلے سینا، کارڈ اور جھلیاں آٹھ سے سولہ گھنٹوں کے اندر اندر خود بخود بغیر کسی پیچیدگی کے یوٹرس سے خارج ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر حمل کی مدت تقریباً 280 دن تصور کی جاتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ حمل کی مدت 280 دن ہی ہو۔ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ بعض خواتین میں بچہ کی پیدائش 280 دن سے کچھ پہلے یا 280 دن سے کچھ بعد میں ہوتی ہے اور بچہ نارمل و صحت مند ہوتا ہے۔ جوں جوں وضع حمل کا وقت قریب آتا چلا جاتا ہے تو یوٹرس کی تشنجی حرکات میں درجہ بدرجہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یوٹرس سکڑ کر اپنے اندر موجود بچے کو باہر نکالنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یوٹرس کے سکڑنے سے زچہ میں درد کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے درد زہ یا لیبر پین کہتے ہیں طبعی وضع حمل کو درج ذیل تین مرحلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؛

Stage of Dilatation	پہلا مرحلہ
Stage of Expulsion	دوسرا مرحلہ
Placental Stage	تیسرا مرحلہ

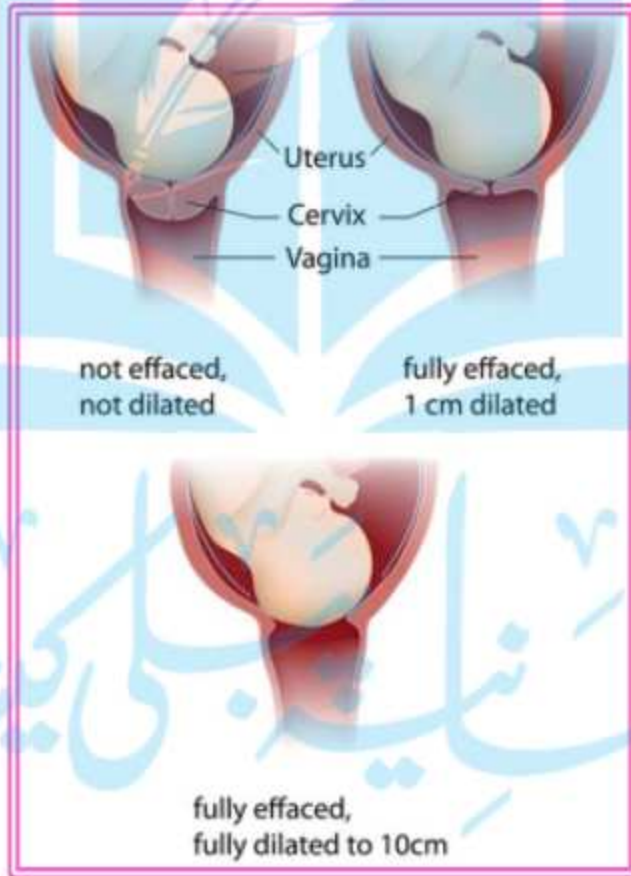
پہلا مرحلہ (Stage of Dilatation): طبعی وضع حمل کا پہلا مرحلہ لیبر پین کے شروع ہونے سے لے کر یوٹرس کے منہ سرویکس کے مکمل طور پر کھل جانے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں جو نہی بچے کے پیدا ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو یوٹرس میں باقاعدہ تشنجی حرکات شروع ہو جاتی ہیں اور یوں یوٹرس پھیلتا اور سکڑتا ہے۔ یوٹرس کے پھیلنے اور سکڑنے سے عورت میں درد کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے لیبر پین کہا جاتا ہے یہ لیبر پین بڑی باقاعدگی اور شدت سے ہوتی ہیں۔ شروع شروع میں ہر بیس سے تیس منٹ

بعد لیبر پین آتے ہیں اور تقریباً آدھ منٹ تک جاری رہتے ہیں یہاں تک کہ زچگی کے آخری اوقات میں یہ دردیں ہر دو تین منٹ بعد ہوتی ہیں اور تقریباً ایک ایک منٹ تک جاری رہتی ہیں۔ ان لیبر پین کے دوران یوٹرس کے بار بار سکڑنے اور پھیلنے کی وجہ سے یوٹرس کا منہ سرویکس کھلتا چلا جاتا ہے اور اس حد تک کھل جاتا ہے کہ سرویکس میں چار انگلیاں با آسانی داخل ہو سکتی ہیں۔ ایسی حالت کو سرویکس کا مکمل پھیلاؤ کہا جاتا ہے اسی دوران یوٹرس سے خون ملے سیال مادے کا اخراج بھی ہوتا ہے سرویکس کے مکمل پھیلاؤ پر بچہ سر کے بل نیچے کی جانب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سرویکس کے پھیل جانے پر اسکے منہ پر پانی کی ایک تھیلی ایمینیاٹک ممبرین نظر آتی ہے جو کہ پھٹ جانے کے بعد لیبر پین کی نوعیت یکسر تبدیل ہو جاتی ہے اور اس طرح طبعی وضع حمل کا پہلا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے۔

دوسرا مرحلہ (Stage of Expulsion): طبعی وضع حمل کا دوسرا مرحلہ سرویکس کے منہ کے کھلنے سے لے کر بچے کی پیدائش تک مشتمل ہوتا ہے۔ ایمینیاٹک ممبرین پھٹ جانے پر لیبر پین جلدی جلدی اور شدت کے ساتھ آنے لگتے ہیں جس کے نتیجے میں بچہ کافی نیچے آ جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ حاملہ عورت میں یہ مرحلہ تقریباً ایک گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے جبکہ ایک عورت اگر پہلے بھی حاملہ رہ چکی ہو اور اس تجربے سے کئی مرتبہ گزر چکی ہو تو یہ مرحلہ مختصر وقت میں گزر جاتا ہے اس مرحلے میں لیبر پین جلدی جلدی آتی ہیں۔ بچے کا سر پیلوک فلور پر نظر آتا ہے بچے کا سرویٹرس کے منہ سرویکس پر دباؤ ڈالتے ہوئے اسے مزید کھول دیتا ہے۔ زچہ خود بھی سانس روک کر نیچے کی جانب زور لگاتی ہے اور اس طرح شدید درد کے ساتھ بچے کا سر اور پھر منہ باہر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد بچے کے دونوں کندھے شدید درد کے ساتھ باہر نکل آتے ہیں پھر پیٹ اور ٹانگیں باہر آ جاتی ہیں اور یوں بچے کی پیدائش کے بعد لیبر پین کچھ دیر کے لئے رک جاتے ہیں اور یوں بچے کی پیدائش کے طبعی وضع حمل کا دوسرا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے۔

تیسرا مرحلہ (Placental Stage): طبعی وضع حمل کا تیسرا مرحلہ بچے کی پیدائش کے بعد سے لے کر یوٹرس سے پلے سینٹا اور جھلیوں کے مکمل اخراج تک مشتمل ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد یوٹرس سکڑ کر چھوٹا ہو جاتا ہے اور لیبر پین تقریباً آٹھ گھنٹے تک بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یوٹرس میں پھر تشنجی حرکات

شروع ہو جاتی ہیں اور یوں یوٹرس کے بار بار سکڑنے اور پھیلنے سے پلے سینا اور اس کی جھلیاں شدید درد کیساتھ خارج ہو جاتی ہیں۔ اس دوران ایک مناسب مقدار میں خون بھی خارج ہوتا ہے۔ اس تیسرے مرحلے میں یوٹرس کے سکڑنے سے یوٹرائن بلڈ ویسلز بھی سکڑنی شروع ہو جاتی ہیں جس سے کہ سیلان خون بھی خود بخود قدرتی طور پر بند ہو جاتا ہے۔ اگر یوٹرس کسی بھی وجہ سے نہ سکڑے تو پھر سیلان خون جاری رہتا ہے جسے پوسٹ پارٹم ہیمنوریج کہتے ہیں۔



نارسل لیبر کے مختلف مراحل

حمل کی ممکنہ پیچیدگیاں

(COMPLICATIONS OF PREGNANCY)

حمل ٹھہرنا ایک قدرتی عمل ہے، بسا اوقات حمل کے دوران کچھ ایسی علامات اور نشانیاں جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جن سے حاملہ اور بچے دونوں کی صحت کے نقصان کا زیادہ احتمال ہوتا ہے لہذا ایسی علامات و نشانیاں کا پہلے ہی تدارک کر لینا چاہیے، نہیں تو یہی علامات بڑھ کر کسی پیچیدگی کی صورت اختیار کر سکتی ہیں۔ حالت حمل میں جو بیماریاں یا علامات ظاہر ہو سکتی ہیں یا بڑھ کر پیچیدگی کی صورت اختیار کر سکتی ہیں وہ درج ذیل ہیں:

صبح کی متلی (Morning Sickness): کئی حاملہ عورتوں میں حمل ٹھہر جانے کے بعد دوسرے ماہ سے متلی و قے کا رجحان ہو جاتا ہے جو کہ عام طور پر تیسرے ماہ کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کئی حاملہ عورتوں میں ہلکی غذا کے استعمال سے بھی متلی و قے کا رجحان کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن اگر یہی متلی اور قے انتہائی شدت اختیار کر جائیں تو حاملہ اور حمل دونوں کیلئے خطرہ بن سکتا ہے اور حاملہ کے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی واقع ہو سکتی ہے ایسی صورت میں بذریعہ ورید ڈرپ لگا کر حاملہ کی اس پیچیدگی کو بروقت کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔

سینے کی جلن (Heart Burning): حمل کے دوران اکثر حاملہ عورتیں معدے یا سینے میں جلن کی شکایت کرتی ہیں جو کہ حمل کے آخری دنوں میں زیادہ ہو سکتی ہے۔ معدے و سینے میں جلن کی وجہ سے معدے میں موجود ہائیڈروکلورک ایسڈ غذا کی نالی ایسوفیگس میں داخل ہو کر جلن کا باعث بنتا ہے، ایسی صورت میں ٹھنڈے دودھ اور دواؤں سے اس کا علاج ممکن ہے۔

تسبض (Constipation): دوران حمل قبض کا ہو جانا بھی ایک عام شکایت ہے، مستقل قبض حاملہ عورت کے لئے نقصان کا باعث بن سکتا ہے لہذا ایسی صورت میں حاملہ کو ہلکی پھلکی غذا کے استعمال سے ہزیوں، پھل اور فروٹ کے استعمال سے یا اسپغول کے چھلکے کے استعمال سے قبض کو موثر طور پر دور کیا جاسکتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے ادویات کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے اور قبض کو قدرتی طریقوں سے ٹھیک ہونے کا موقع دینا چاہیے۔

اسہال (Diarrhoea): بسا اوقات کسی بھی وجہ سے حاملہ عورتوں میں اچانک اسہال کی بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہے جو کہ کھانے پینے کی بد احتیاطی یا جراثیموں کے انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اسہال کی بیماری میں حاملہ پانی اور نمکیات کی کمی کا شکار ہو سکتی ہے اور یہاں تک کہ پیچیدگی کے طور پر ابارشن بھی ہو سکتا ہے لہذا ابتداء ہی سے اسہال پر توجہ دینی چاہیے اور مناسب علاج کرنا چاہیے۔

بواسیر (Piles): جو خواتین کسی بھی وجہ سے دوران حمل پیدل چلنے پھرنے سے قاصر ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اگر قبض کا بھی شکار ہو جائیں تو عموماً ایسی خواتین حمل کے آخری دنوں میں بواسیر کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ایسی کنڈیشن میں بھی حاملہ کو قبض دور کرنے والی غذاؤں اور سیال اشیاء کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔

اڈیما (Oedema): حمل کے دوران کئی عورتوں میں اڈیما کی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے حاملہ عورتیں چہرے، ہاتھوں اور پیروں پر ورم آ جانے کی شکایت کرتی ہیں۔ ایسا عموماً حاملہ کے خون کے پتلا ہو جانے یا پھر بلڈ سرکولیشن میں تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن بہر صورت حاملہ کے اس اڈیما کو تشخیص کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے اور پیشاب کے علاوہ اس کے دوسرے لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ بھی کئے جاتے ہیں تاکہ اڈیما کی اصل وجوہات معلوم کر کے اس کا بروقت صحیح طور پر علاج کیا جائے۔

ناٹگوں کی وریدوں کا پھولنا (Varicose Veins): کئی حاملہ عورتوں میں حمل کے آخری دنوں میں ناٹگوں کی وریدیں پھول جایا کرتی ہیں جسکی عام وجہ بلڈ سرکولیشن میں تبدیلی واقع ہو جانا ہے۔ ناٹگوں کی وریدیں پھول جانے کے بعد ان میں اڈیما اور سوجن و درد بھی ہو جایا کرتا ہے اس ضمن میں حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ زیادہ دیر تک کھڑا ہونے یا بیٹھ لٹکانے سے پرہیز کرے۔

شرمگاہ کی حساسیت (Pruritis Vulvae): حمل کے دوران کئی حاملہ عورتوں میں ویجائنہ کے راستے خراش دار رطوبتوں کا اخراج ہوا کرتا ہے جو کہ شرمگاہ کی خارش اور تکلیف کا باعث بنا کرتا ہے۔ دوران حمل حاملہ کو چاہیے کہ وہ شرمگاہ کی صفائی کا خیال رکھے تاکہ شرمگاہ کی یہ خارش مزید نہ بڑھنے پائے۔

تھوک کی زیادتی (Ptyalism): حمل کے دوران کئی حاملہ عورتیں تھوک کی کثرت میں مبتلا ہو جاتی ہیں جسکی وجہ سے انکے منہ کا ذائقہ بد مزہ ہو جاتا ہے اور وہ مریج مصالحوں والی چٹ پٹی اشیاء کھانا پسند کرتی ہیں۔

مٹی کھانے کی خواہش (Mud Eating): حمل کے دوران کمیشنم کی کمی کے باعث کئی حاملہ عورتوں میں مضر صحت اشیاء مثلاً مٹی، گاجی، چاک، کونکہ وغیرہ کھانے کی شدید خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی مضر صحت اشیاء کھانے کے استعمال سے حاملہ عورت کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہونے اور خون کی کمی ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے جو کہ حاملہ، حمل اور بچے سب کے لئے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔

نیند کی کمی (Insomnia): حمل کے آخری مہینوں میں یوٹرس کا سائز بڑھ جانے اور مثانہ پر دباؤ پڑنے سے حاملہ کو بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے حاملہ کو رات میں بھی بار بار پیشاب آتا ہے اور وہ صحیح طور پر اپنی نیند پوری نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ پیٹ میں موجود بچے کی حرکات کی وجہ سے بھی حاملہ گہری نیند نہیں سو سکتی۔

خون کی کمی (Anaemia): حاملہ عورت کو روزمرہ خوراک میں آئرن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے جسم کے علاوہ بچے کے آئرن کی بھی ضرورت پوری کر سکے لیکن بسا اوقات غیر متوازن غذا کے استعمال سے غذا کی کمی، بھوک کی کمی اور اسہال کی بیماری کی وجہ سے حاملہ میں خون کی کمی واقع ہو سکتی ہے اور ایسا عموماً ان حاملہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے جو کئی بچوں کو جنم دے چکی ہوں۔

☆☆☆☆☆☆

عثمانیہ سلیکشنز

استقاطِ حمل - ابارشن (ABORTION)

حمل ٹھہر جانے کے بارہ ہفتوں کے بعد اور اٹھائیس ہفتوں سے پہلے اگر بچہ، یوٹرس میں مر جائے یا پھر یوٹرس سے خارج ہو جائے تو اسے استقاطِ حمل یا حمل کا ضائع ہونا یا ابارشن کہا جاتا ہے۔

ابارشن کی وجوہات (Etiology): کروموسومز کی وجہ سے زائگوٹ کا صحیح نہ بننا۔ فیشس کاماں کی قوت مدافعت کے خلاف ری ایکشن کرنا۔ ماں کو لاحق بیماریوں مثلاً خسرہ، سفلس، ذیابیطس یا غیر متوازن غذا یا غذا کی کمی کی وجہ سے بھی ابارشن ہو سکتا ہے۔ یوٹرس کی خرابیوں مثلاً یوٹرس میں جھلی پیدا ہونا۔ یوٹرس میں رسولی یا کینسر کی وجہ سے بھی ابارشن ہو سکتا ہے۔ کئی ادویات کے استعمال مثلاً کونین، ارگٹ، زہریات یا پچوٹری ہارمون سے تیار کردہ ادویات کے استعمال سے بھی ابارشن ہو سکتا ہے۔ حادثاتی طور پر گر جانے سے بھی ابارشن ہو سکتا ہے۔ اچانک جذباتی دباؤ مثلاً ڈر، خوف، صدمہ، ذہنی و نفسیاتی دباؤ کے باعث بھی ابارشن ہو سکتا ہے۔ اینڈوکرائن ہارمونز کی کمی کی وجہ سے بھی ابارشن ہو سکتا ہے۔ وٹامن ای کی کمی وجہ سے بھی ابارشن ہو سکتا ہے خون کی کمی کی شکار عورتوں میں بھی ابارشن ہو جایا کرتا ہے۔ کئی بچوں کو جنم دینے والی ماؤں میں سرویکس کے ڈھیلا ہو جانے کی وجہ سے بھی ابارشن ہو جایا کرتا ہے۔ حاملہ عورت کو اگر بہت زیادہ تھوڑے وقت میں آئیں اور جسم میں نمکیات کی کمی واقع ہو جائے تو بھی استقاطِ حمل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حاملہ کا زیادہ کام کاج کرنا بھی ابارشن کا باعث بن سکتا ہے۔ عورتوں میں ابارشن کی سب سے زیادہ عام وجہ زیادہ وزن کا اٹھانا ہے۔

ابارشن کی علامات (Signs & Symptoms): حاملہ کو پیڑوں کے مقام پر درد شروع ہو جائے گا۔ حاملہ کی اندام نہانی سے خون کا اخراج شروع ہو جائے گا۔ نبض کی رفتار تیز ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر کم ہو جائے گا۔ پیلووس میں درویں ہوتی محسوس ہوں گی۔ حاملہ کو حیض جیسی درویں محسوس ہوں گی۔ ویجائنہ کے ذریعے فیشس پلے سینٹا یا کارڈ کے حصوں کا اخراج ہو گا۔ حاملہ شک یعنی صدمے کی حالت میں بھی جاسکتی ہے۔

ہو میو پیٹھک علاج: وائی برنم آپولس Q، پندرہ قطرے دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

اسقاطِ حمل کا انگریزی علاج

➤	Tab E.Vion 400mg	ایک روزانہ
➤	Tab ALP 0.5mg	ایک روزانہ رات
➤	Cap Transamin 500mg	1+1+1 کھانے کے بعد

☆☆☆☆☆☆

عُثْمَانِيَّةٌ بِلِي كِيشَن

بے محل حمل۔ ایکٹاپک۔ پریگ۔ نینسی

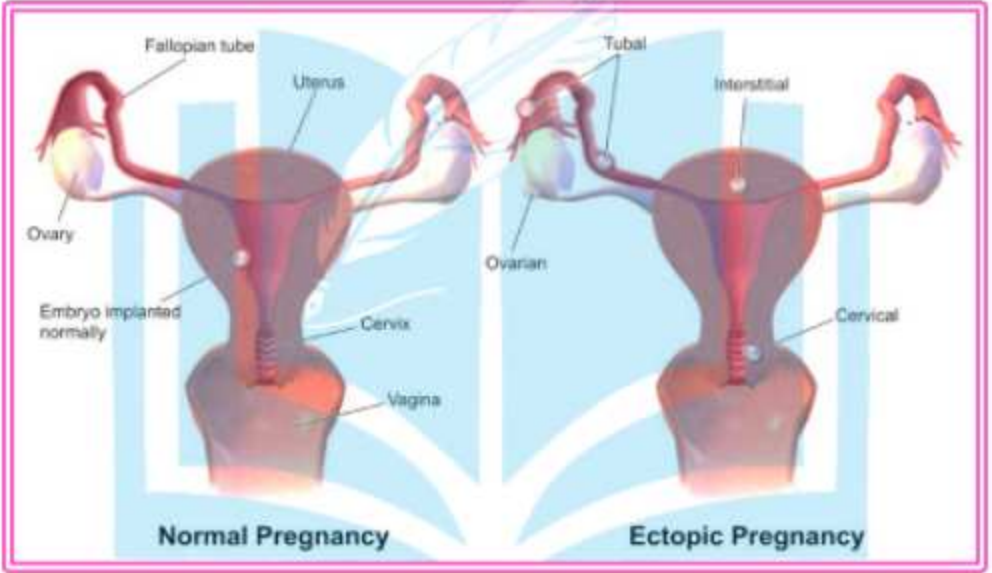
(ECTOPIC PREGNANCY)

اگر حمل یوٹرس کے علاوہ کسی اور جگہ مثلاً فیلوپین ٹیوب، اووری، سرویکس وغیرہ میں ٹھہر کر بڑھنے لگے تو اسے ایکٹاپک پریگ نینسی یا بے محل حمل کہتے ہیں۔ عام طور پر حمل فیلوپین ٹیوب میں ہی قرار پاتا ہے جو کہ بعد میں یوٹرس کی جانب ٹرانسفر ہوتا ہے اور نو مہینے تک یوٹرس میں ہی بڑھتا رہتا ہے۔

بے محل حمل کی وجوہات (Etiology): اگر فیلوپین ٹیوب میں کوئی نقص ہو تو حمل وہیں پر بڑھنے لگتا ہے۔ بسا اوقات سینے کا حجم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ یوٹرس میں داخل نہیں ہو سکتا، کئی مرتبہ فیلوپین ٹیوب غیر معمولی طور پر لمبی گہری اور خم دار ہو سکتی ہے۔ پروجیسٹرولن ہارمون کی زیادتی کی وجہ سے فیلوپین ٹیوب کی حرکات میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ فیلوپین ٹیوب کی سوزش کی وجہ سے ٹیوب کی حرکات ناکارہ ہو سکتی ہیں اور بیضہ حرکات نہ ہونے کی وجہ سے وہیں رک کر بڑھنے لگتا ہے۔ بعض اوقات فیلوپین ٹیوب میں ایک کی جگہ دو یا کئی سوراخ ہو سکتے ہیں۔ فیلوپین ٹیوب کی سوزش کی صورت میں ٹیوب کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے اور بیضہ وہاں سے نہیں گزر سکتا۔ اگر ٹیوب سکڑ کر بند ہو گئی ہو۔ فیلوپین ٹیوب کی نشوونما صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بھی بے محل حمل قرار پا سکتا ہے۔ اگر یوٹرس کی اندرونی تہہ اینڈومیٹریئم غیر معمولی طور پر موٹی ہو جائے۔

علامات و نشانی (Signs & Symptoms): حاملہ پیلووس میں ہر وقت ہلکے ہلکے درد کی شکایت کرتی ہے جو کبھی کبھی شدید بھی ہو جاتا ہے۔ فیلوپین ٹیوب میں حمل ٹھہرانے والی حاملہ خواتین میں ہر وقت فیلوپین ٹیوب کے مقام پر غیر معمولی کھنچاؤ اور درد کی سی کیفیت رہتی ہے۔ پیشاب بار بار آتا ہے۔ حاملہ خون کی کمی کا شکار ہوتی ہے۔ حاملہ کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑ جاتے ہیں اور آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں۔ درد کی کیفیت میں حاملہ کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ شدید درد کی صورت میں حاملہ شاک یعنی صدمے کی حالت میں بھی جاسکتی ہے۔ شدید درد کی صورت میں بلڈ پریشر گر جاتا ہے۔ حاملہ کو متلی اور تھکتی ہوئی ہے اور چکر آتے ہیں۔ جب فینئس کی موت واقع ہو جائے تو جریان خون شروع ہو جاتا ہے۔

علاج (Treatment): جب حاملہ کو پیڑو میں شدید درد ہوتا ہے یا پھر ویجاٹل بلیڈنگ ہوتی ہے تو حاملہ کا الٹراساؤنڈ کیا جاتا ہے جس سے کہ ایکٹا پک پرگ نینسی کی تشخیص ہو جاتی ہے اور پھر حاملہ کو سرجری کے لئے ریفر کر دیا جاتا ہے جہاں کہ حاملہ کا پیٹ سرجری کے ذریعے چاک کر کے حمل ضائع کر دیا جاتا ہے۔



نارسل اور ایکٹا پک پرگ نینسی کا تقابلی جائزہ

☆☆☆☆☆☆

عُشْنِیَہ کی کیشنر

پرسوت کا بخار

(PUERPERAL FEVER)

زچگی کے دوران جس کا عرصہ چھ ہفتوں پر محیط ہوتا ہے اگر کسی بھی وجہ سے زچہ کے جسم کا درجہ حرارت 100 ڈگری فارن ہائیٹ سے بڑھ جائے تو ایسے بخار کو پرسوت کا بخار کہتے ہیں۔

وجوہات (Etiology): اعضائے مخصوصہ کا انفیکشن۔ پستان کی سوزش۔ نظام بول کا انفیکشن۔

علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms): حاملہ کو بخار زیادہ ہوتا جائے گا۔ حاملہ کو ٹھنڈ یا سردی لگے گی۔ حاملہ کو کپکپاہٹ و لرزہ محسوس ہوگا۔ بخار 103 ڈگری سے لے کر 105 ڈگری فارن ہائیٹ تک ہوگا۔ نبض کی رفتار تیز ہوگی۔ سر میں درد ہوگا۔ کمر میں درد ہوگا۔ پیٹ میں درد ہوگا۔ تمام جسم میں درد ہوگا۔ بعض اوقات حاملہ کو متلی اور قے بھی ہوگی۔ حاملہ کو بعض اوقات ہڈیاں بھی ہو سکتا ہے۔

علاج (Treatment): زچگی کے بعد تمام انفیکشنوں کی روک تھام کرنی چاہیے۔ حاملہ کی جزل صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ حاملہ کو اپنے اعضائے مخصوصہ و پیشانی راستوں کی صفائی و ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ زچہ کی خوراک، رہائش اور لباس سب حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہونی چاہئیں۔

ہومیوپیتھک علاج: ہیپر سلف 200 صبح نہار دیں۔ سلیشیا 200 رات سوتے وقت دیں۔

پرسوت کے بخار کا انگریزی علاج

➤	Cap Cefspan 400mg	1+1 کھانے کے بعد
➤	Tab Panadol	2+2+2 کھانے کے بعد

بانجھ پن - انفرٹیلیٹی

(INFERTILITY)

بانجھ پن سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک شادی شدہ جوڑا نارمل طور پر کم از کم ہفتے میں دو مرتبہ جنسی فعل سرانجام دیتا ہے اور اگر دو سال کے بعد بھی ان کے ہاں حمل نہیں ٹھہرتا تو اس حالت کو بانجھ پن کہتے ہیں۔

بانجھ پن کی اقسام (Types): بانجھ پن کی درج ذیل دو اقسام ہیں:

پرائمری بانجھ پن (Primary Infertility): ایک ایسا جوڑا جس کے ہاں شادی کے بعد کبھی بھی حمل نہ ٹھہرا ہو۔

سیکنڈری بانجھ پن (Secondary Infertility): ایک ایسا جوڑا جس کے ہاں کم از کم پہلے ایک مرتبہ حمل ٹھہرا ہو چاہے پھر اس حمل کی خود بخود بارش ہو گئی ہو۔

عورتوں میں بانجھ پن کی وجوہات (Etiology): عورتوں میں بانجھ پن کی ایک وجہ عمر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ بلوغت سے پہلے اور سن یاس کے بعد حمل نہیں ٹھہر سکتا۔ عورتوں میں بانجھ پن کی ایک وجہ عام جسمانی بیماری مثلاً تپ دق، گردوں کی بیماری، یرقان، جگر کی سختی اور ذیابیطس وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں۔ بانجھ پن کی ایک اور وجہ خوراک کی کمی یا غیر متوازن خوراک بھی ہے۔ شادی کے بعد جنسی تعلقات میں کمی بھی بانجھ پن کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ بانجھ پن کی ایک اور بڑی وجہ عورتوں میں نفسیاتی پیچیدگیاں بھی ہیں مثلاً خوف، ڈر، پریشانی، گھبراہٹ، ذہنی تناؤ اور دباؤ، شادی کے بعد کے گھریلو جھگڑے وغیرہ بھی بانجھ پن کا سبب بن سکتے ہیں کیونکہ ان حالات کے زیر اثر عورتوں میں فیلوپین ٹیوبز سکڑ کر بانجھ پن پیدا کر سکتی ہیں اور لڑائی جھگڑے و نفسیاتی پیچیدگیوں کے باعث جنسی تعلقات میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ عورتوں میں بانجھ پن کی ایک اور بڑی عام وجہ اووریز کافیل ہو جانا ہے۔ کئی مرتبہ جنسی ہارمونز کے غیر متوازن ہونے کی وجہ سے بھی بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ کئی مرتبہ عورت کی فیلوپین ٹیوبز میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہو جانے کے بعد بھی حمل نہیں ٹھہرتا اور بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ عورتوں میں یوٹرس میں فائبرائیڈز یا رسولی کے باعث بھی بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ بانجھ پن

کی ایک بڑی وجہ اینڈومیٹریٹس کی کمی ہو سکتی ہے۔ بانجھ پن کی ایک اور وجہ تھائی رائیڈ گلیٹنڈ کا کم یا زیادہ کام کرنا بھی ہے۔ ذیابیطس کی بیماری بھی بانجھ پن کا سبب بن سکتی ہے۔ کئی مرتبہ یوٹرس اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے یا اس میں ہل پڑ جانے کی وجہ سے بھی بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ کئی مرتبہ یوٹرس پیدائشی طور پر ہوتا ہی نہیں ہے یا پھر بہت چھوٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بانجھ پن دیکھنے میں آتا ہے۔ کئی مرتبہ ویجائنہ سے خراش دار مادے لیکوریا کا بہت زیادہ اخراج ہوتا ہے جس سے ویجائنہ میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے جو مرد کے اسپرمز کو تباہ کر دیتی ہے اور یوں بانجھ پن دیکھنے میں آتا ہے۔ کئی عورتوں میں سرویکس قدرتی طور پر کافی تنگ ہوتا ہے یا سرویکس کے مقام پر سوزش ہوتی ہے اور جو بانجھ پن کا سبب بنتی ہے۔ کئی عورتوں میں وٹامن "ای" کی کمی بھی بانجھ پن کا باعث بنتی ہے۔ کئی عورتوں میں مردانہ اوصاف کے زیادہ ہو جانے پر بھی بانجھ پن ہوتا ہے۔ حیض کی بے قاعدگی اور دیگر جنسی بیماریاں بھی بانجھ پن کا موجب ہو سکتی ہیں۔ جماع کے دوران شدید تکلیف بھی بانجھ پن پیدا کر سکتی ہے۔ کئی مرتبہ شوہر اور بیوی میں ذہنی مطابقت نہ ہونے کی وجہ سے بھی بانجھ پن دیکھنے میں آتا ہے۔

عورتوں میں بانجھ پن کی تشخیص (Diagnosis): عورتوں میں بانجھ پن کی تشخیص کے لئے درج ذیل ٹیسٹ کئے جاتے ہیں؛

◀ عورت کے سرویکس کا مواد لے کر لیبارٹری میں ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تاکہ اندازہ لگایا جاسکے کہ کوئی نقصان دہ مادہ تو خارج نہیں ہو رہا جو بانجھ پن کی تشخیص میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

◀ اینڈومیٹریل بائیوپسی بانجھ پن کی تشخیص میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس میں اینڈومیٹریٹس کا چھوٹا سا ٹکڑا لیکر ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آیا اینڈومیٹریٹس کی کمی یا کمیئر تو نہیں یا کسی اور وجہ سے اینڈومیٹریٹس تباہ تو نہیں ہو گئی۔

◀ ٹیوبل پونینسی ٹیسٹ بھی بانجھ پن کی تشخیص میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس ٹیسٹ میں سرویکس کے راستے آلات کی مدد سے کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس داخل کر کے اس کی آواز ناف کے نیچے شیتھو سکوپ کی مدد سے سنی جاتی ہے۔ آواز آنے کا مطلب فیلوپین ٹیوب کھلی ہیں اور نارمل حالت میں ہیں۔

◀ بانجھ پن کی تشخیص میں ایک اہم ٹیسٹ پوسٹ کوانٹل ٹیسٹ ہے۔ اس ٹیسٹ میں جنسی ملاپ کے چھ سے اٹھارہ گھنٹوں کے درمیان سرویکس کے قریب رطوبت حاصل کر کے سپرمز کی حالت دیکھتے ہیں۔

❖ لیپر اسکوپ بھی بانجھ پن کی تشخیص کا ایک اعلیٰ ترین ٹیسٹ ہے اس ٹیسٹ میں آلات کی مدد سے فیلوپین ٹیوبز اور ریز کی کارکردگی کا معائنہ کیا جاتا ہے۔

❖ الٹراساؤنڈ سے بھی پیلولس کے اعضاء کی ساخت وغیرہ کا مشاہدہ بانجھ پن کی تشخیص میں مدد دیتا ہے۔

❖ اس کے علاوہ دیگر جنسی امراض کی تشخیص کے لئے بھی خون اور پیشاب کے ٹیسٹ کئے جاسکتے ہیں۔

ہومیوپیتھک علاج: ہیلونا ز+Q+الشو کا Q ملا کر پندرہ قطرے دن میں تین مرتبہ دیں

بانجھ پن کا انگریزی علاج		
➤	Cap E.Vion 400mg	ایک کیپسول روزانہ
➤	Syp Aletris Cordial	1+1+1 کھانے کے بعد

☆☆☆☆☆☆☆☆

عُثْمَانِيَّة بِلِي كِيشَن

بندش حیض - اے مینوریا

(AMENORRHOEA)

عورتوں یا لڑکیوں میں حیض کا بند ہو جانا، بندش حیض یا ایمینوریا کہلاتا ہے۔

ایمینوریا کی اقسام (Types): ایمینوریا کی درج ذیل دو اقسام ہیں؛

پرائمری ایمینوریا: اگر کسی عورت کو کبھی بھی حیض جاری نہ ہوا ہو تو اس حالت کو پرائمری ایمینوریا کہتے ہیں۔

سیکنڈری ایمینوریا: اگر کسی عورت کو حیض جاری ہوئے ہوں اور پھر بعد میں حیض آنا رک جائے تو اس حالت کو سیکنڈری ایمینوریا کہتے ہیں۔

ایمینوریا کی درجہ بندی (Classification): درجہ بندی کے لحاظ سے ایمینوریا کو درج ذیل اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

1۔ فزیالوجیکل ایمینوریا یعنی طبعی بندش حیض جو کہ درج ذیل صورتوں میں ہو سکتا ہے؛

(ا) بلوغت سے پہلے۔

(ب) حمل کے دوران۔

(ج) دودھ پلانے کے زمانے میں۔

(د) سن یاس کے زمانے میں۔

درج بالا ایمینوریا کی کنڈیشن چونکہ فزیالوجیکل ہیں لہذا اس اقسام کے ایمینوریا کا کوئی علاج نہیں کیا جاتا یہ ایمینوریا قدرتی طور پر ہوتے ہیں۔

2۔ پیٹھولاجیکل ایمینوریا یعنی غیر طبعی بندش حیض جو کہ درج ذیل صورتوں میں ہو سکتا ہے؛

یوٹرس کی بیماریوں کی وجہ سے بندش حیض جیسا کہ یوٹرس کی ٹی بی میں ہو سکتا ہے۔ اور یز کی بیماریوں کی وجہ سے بندش حیض جیسا کہ اووریز میں سٹ پیدا ہو جائیں۔ پچوٹری گلینڈ کی بیماریوں کی وجہ سے بندش حیض مثال کے طور پر پچوٹری کے اگلے حصے کی نیکروسس ہو جائے یا پچوٹری گلینڈ چھوٹا رہ جائے یا پچوٹری گلینڈ کے اگلے

جسے میں رسولی پیدا ہو جائے۔ اینڈوکرائن گلینڈز کی خرابیوں کی وجہ سے بندش حیض مثال کے طور پر اگر ایڈرنل گلینڈ میں رسولی یا ٹیومر ہو جائے۔ کریپٹو مینوریامیا میں بھی بندش حیض ہوتی ہے۔ اس کنڈیشن میں ہائی مین یعنی پردہ بکارت کا سوراخ تنگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے حیض کا خون باہر نہیں نکل سکتا۔ نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے بھی ایمنیوریامیا ہو سکتا ہے۔ جذباتی دباؤ اور تناؤ بھی ایمنیوریامیا کا باعث ہو سکتا ہے۔ مختلف ادویات کا زیادہ استعمال بھی ایمنیوریامیا کا باعث بن سکتا ہے مثال کے طور پر مانع حمل ادویات کا استعمال، ہارمونل یا سٹیرائڈ ادویات کا زیادہ استعمال بھی بندش حیض کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح اگر زیادہ پیلوک ایکسے کر دئے جائیں تو بھی ایمنیوریامیا ہو سکتا ہے۔ ہائیپو تھیلامیا کی خرابیوں کی وجہ سے بھی ایمنیوریامیا ہو سکتا ہے۔ تھائی رائیڈ گلینڈ کے ہارمونز کی کمی یا زیادتی بھی ایمنیوریامیا کا باعث بنتی ہے۔ یوٹرس کا پیدا انشی طور پر نامکمل ہونا، چھوٹا ہونا یا نہ ہونا بھی ایمنیوریامیا کا باعث بنتا ہے۔ جسم میں خون یا آئرن کی کمی بھی ایمنیوریامیا کا باعث بنتی ہے۔ درج بالا ایمنیوریامیا کی کنڈیشن چونکہ پیسٹھولا جیکل ہیں لہذا مریضہ میں تشخیص کر کے اسکے مطابق ایمنیوریامیا کا علاج کیا جاتا ہے۔

پیسٹھولا جیکل ایمنیوریامیا کی علامات (Signs & Symptoms): مریضہ کمزور و محسوس کرتی ہے۔ مریضہ کو پیلوکس میں بھی درد محسوس ہوگا۔ مریضہ میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ مریضہ میں افسردگی پائی جاتی ہے۔ مریضہ میں بے زاری پائی جاتی ہے۔ مریضہ میں مایوسی پائی جاتی ہے مریضہ میں چڑچڑاہٹ پائی جاتی ہے۔ یوٹرس میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ کمزور مریضاؤں میں ایسیا کی علامات بھی پائی جاتی ہیں۔ کئی عورتوں میں ماہواری کے دنوں میں پیڑوں میں دردیں ہو گئی لیکن ماہواری نہیں آتی۔ ہارمونل تبدیلیوں کی وجہ سے کئی عورتوں میں موناپے کی جانب رجحان ہوگا۔ کئی عورتیں نحیف، کمزور اور ناتواں ہو گئی۔

علاج (Treatment): ایمنیوریامیا کا علاج درج ذیل اصولوں کے تحت کرنا چاہیے؛

➤ پیسٹھولا جیکل ایمنیوریامیا کی وجہ تشخیص کر کے علاج کیا جانا چاہیے۔

➤ ایسیا ہو تو اس کا علاج کرنا چاہیے۔

➤ ہلکی ورزش اور متوازن خوراک کا استعمال کرنا چاہیے۔

➤ حفظانِ صحت کے اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے۔

ہو میو پیٹھک علاج: گوئیپیٹیم Q+ایس Q ملا کر دس قطرے دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بند شش حیض کا انگریزی علاج

➤	Tab Premarin 0.625mg	ماہواری ختم ہونے کے بعد سے پچیس دن تک ایک گولی روزانہ استعمال کریں
➤	Tab Nospa Forte	1+1 کھانے کے بعد
➤	Syp Iberet 500	1+1 کھانے کے بعد

☆☆☆☆☆☆

عُثْمَانِیَّة سِلَی کیشنر

دقتِ حیض - ڈس مینوریا (DYSMENORRHOEA)

عورتوں یا لڑکیوں میں حیض کا درد کے ساتھ آنا ڈس مینوریا کہلاتا ہے۔

ڈس مینوریا کی وجوہات (Etiology): اعضائے مخصوصہ میں کینسر پیدا ہونے سے پہلے کی حالت میں حیض درد کے ساتھ آسکتے ہیں۔ یوٹرس میں اگر فائبروما کی کنڈیشن پیدا ہو جائے۔ اعضائے مخصوصہ کے آس پاس کے انفیکشن کی وجہ سے بھی ڈس مینوریا کی کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہے۔ بلوغت کی شروعات میں بھی دقت حیض ہو سکتا ہے۔ اعضائے مخصوصہ میں تشنجی کیفیات کی وجہ سے بھی ڈس مینوریا کی کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہے۔ نفسیاتی پیچیدگیوں کی وجہ سے بھی یہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ یوٹرس کی الرجی کی وجہ سے اگر یوٹرس کے مسلز سکڑ جائیں تو بھی دقت حیض کا مرض ہو سکتا ہے۔ یوٹرس میں پیدائشی طور پر اگر کوئی نقص ہو تو بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اگر پیلوک آرگنز کی کوئی پرانی بیماریاں ہوں۔ اگر دورانِ حیض یوٹرس کے عضلات نہایت شدت سے سکڑیں اور پھیلیں تو ان عضلات میں ٹوٹ پھوٹ ڈس مینوریا کا باعث بنتی ہیں۔ یوٹرس کے عضلات میں خون کی کمی واقع ہونے کے باعث بھی ڈس مینوریا ہو سکتا ہے۔ بسا اوقات، ہسٹریا کی وجہ سے بھی ڈس مینوریا ہو سکتا ہے۔ اعصابی کمزوری بھی اس مرض کی ایک بڑی وجہ ہے۔ یوٹرس میں درم ہو جانے یا یوٹرس کے پیچھے کی جانب ٹل جانے کی وجہ سے بھی دقت حیض ہو سکتا ہے حیض کے خون کے بہاؤ میں کسی قسم کی رکاوٹ بھی تکلیف کا باعث بن سکتی ہے۔

ڈس مینوریا کی علامات (Signs & Symptoms): حیض آنے سے دو یا تین دن پہلے درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ درد ٹھیک ہوتا جاتا ہے جوں جوں حیض جاری ہوتا جاتا ہے۔ مریضہ کو کمزور درد ہوتا ہے پیلوس میں بھی درد ہوتا ہے۔ مریضہ کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتی ہے۔ مریضہ مکمل آرام کرنا چاہتی ہے۔ مریضہ کے سر میں درد ہوتا ہے۔ مریضہ تمام جسم میں درد محسوس کرتی ہے۔ مریضہ کو یوٹرس میں بھاری

پن محسوس ہوتا ہے۔ حیض کھل کر ہونے کی صورت میں دردوں میں کمی آ جاتی ہے۔ چند ایک کیسز میں مریضہ کو ڈس مینوریا کا درد اتنی شدید نوعیت کا ہوتا ہے کہ مریضہ درد کی شدت سے نڈھال ہو جاتی ہے، بعض حالتوں میں جسمانی دردوں کے علاوہ مریضہ کو قے یا متلی بھی ہوتی ہے۔ مریضہ کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے اور مریضہ بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتی ہے۔

علاج (Treatment): نوجوان لڑکیوں کو حیض سے متعلق معلومات فراہم کرنی چاہئیں تاکہ حیض شروع ہونے پر خوف کی وجہ سے وہ ڈس مینوریا میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ درد کش ادویات دینی چاہئیں۔ مناسب آرام کا مشورہ دینا چاہیے۔ متوازن خوراک کے استعمال کا مشورہ دینا چاہیے۔ حفظانِ صحت کے اصول اپنانے کا مشورہ دینا چاہیے۔ گرم پانی کی بوتل سے پیٹ کے نچلے حصے کو گرمائش اور ٹکور دینی چاہیے۔

ہومیوپیتھک علاج: کالوفاکلم 30 صبح نہار دیں۔ سہی سی فوگا 30 رات سوتے وقت دیں۔

وقتِ حیض کا انگریزی علاج

➤	Tab Buscopan Plus	1+1+1 کھانے کے بعد
➤	Tab Caflam 50mg	1+1 کھانے کے بعد

☆☆☆☆☆☆☆☆

بے قاعدہ کثرت حیض۔ میٹرورجیا (METRORRHAGIA)

دوماہواریوں کے درمیان ماہواری ہونے کو میٹرورجیا کہتے ہیں۔

میٹرورجیا کی وجوہات (Etiology): میٹرورجیا کی عام وجوہات درج ذیل ہیں:

ہارمونز کا بے قاعدہ ہونا۔ سرویکس کا کینسر۔ اینڈومیٹریٹس کا کینسر۔ انفیکشن مثلاً سرویکس کی سوزش، اینڈومیٹریٹس کی سوزش، بلڈ پلیٹ لیٹس کی کمی کی بیماری پر۔ نفسیاتی پیچیدگیاں۔ جگر کی بیماریاں۔ ولادت کے بعد یوٹرس میں پلے سینا کے کسی ٹکڑے وغیرہ کا رہ جانا۔ ابارشن کی وجہ سے بھی میٹرورجیا ہو سکتا ہے۔ پچوٹری ہارمونز کا زیادہ اخراج ہونا۔ تھائی رائیڈ گلیٹنڈ کے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے۔ اووریز کے کینسر میں جبکہ اووریرین ہارمونز زیادہ خارج ہوں۔ پروجیسٹران کی کمی اور ایسٹروجنز کی زیادتی ہو۔ یوٹرائن فابریکٹز کی وجہ سے۔ ویجائن میں السر، کینسر یا سوزش کی وجہ سے بھی میٹرورجیا ہو سکتا ہے۔

میٹرورجیا کی علامات (Signs & Symptoms): اس کی علامات درج ذیل ہیں:

بہت زیادہ ویجائنل بلیڈنگ ہوتی ہے۔ دوماہواریوں کے درمیان بھی بار بار ویجائنل بلیڈنگ ہوتی ہے۔ مریضہ کا رنگ پیلا ہوگا۔ بلڈ پریشر کم ہوگا۔ مریضہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوگی مریضہ دل ٹپٹنے کی شکایت کرتی ہے۔ مریضہ میں اینیمیا پایا جاتا ہے۔ مریضہ کا ایس آر زیادہ ہوتا ہے۔ مریضہ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ چکر آتے ہیں۔ بسا اوقات متلی وقتے ہوتی ہے۔ مریضہ میں کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی مریضہ کو پیٹ کے نچلے حصے ہائپو گیسٹریک میں درد محسوس ہوتا ہے۔ مریضہ کی آنکھوں کے گرد حلقے پائے جاتے ہیں۔ مریضہ ہر وقت آرام کرنا چاہتی ہے۔

ہو میو پیٹھک علاج: سیکیل کار 30+ سپیا 30+ سبانا 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

بے وقت آمد کثرت حیض کا انگریزی علاج

➤	Cap Transamin 500mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➤	Cap Fefol-Vit	ایک کیپسول روزانہ
➤	Tab Primolut-N	لیڈی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ایک گولی روزانہ

☆☆☆☆☆☆

عُثْمَانِيَّةٌ بِلِي كِيشَن

فیلوپین ٹیوبز کی سوزش - سال پن جائی ٹس (SALPINGITIS)

عورتوں میں قاذف نالیوں یعنی فیلوپین ٹیوبز کی سوزش کو سال پن جائی ٹس کہتے ہیں۔

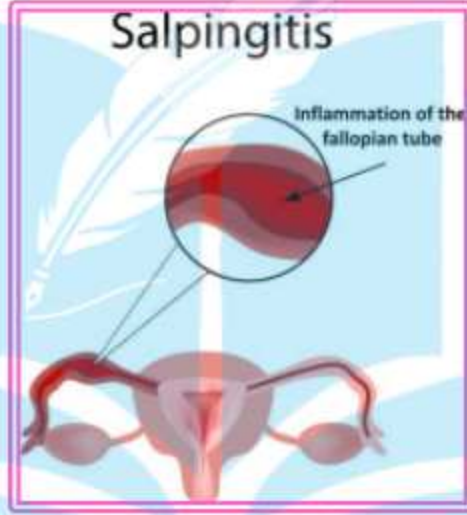
وجہات (Etiology): فیلوپین ٹیوبز کا انفیکشن۔ یوٹرس کی سوزش۔ اینڈومیٹرائٹ کی سوزش۔ اووریز کی سوزش۔ یوٹرس کا کینسر۔ یوٹرس کا فائبروما۔ زچگی کے بعد سوزش پھیل کر فیلوپین ٹیوبز تک آسکتی ہے۔ سوزاک بھی فیلوپین ٹیوبز کی سوزش کر سکتا ہے۔ استقاط حمل کی وجہ سے بھی یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔

علامات و نشانی (Signs & Symptoms): مریضہ پیڑو کے دونوں جانب یا ایک جانب درد کی شکایت کرتی ہے۔ حیض کے دوران درد ہوتا ہے۔ پیٹ کے نچلے حصے پیڑو میں درد ہوتا ہے۔ فیلوپین ٹیوبز سے پانی جیسی رطوبت کا اخراج ہوتا ہے۔ فیلوپین ٹیوبز سے پیپ جیسی رطوبت کا بھی اخراج ہو سکتا ہے۔ فیلوپین ٹیوبز سے خون ملی رطوبت کا بھی اخراج ہو سکتا ہے۔ مریضہ کو بہت زیادہ بخار ہوتا ہے۔ حیض میں بے قاعدگی آجاتی ہے۔ پیشاب پاخانے کے وقت پیٹ کے نچلے حصے میں درد بڑھ جاتا ہے۔ لیکوریائی شکایت ہو جاتی ہے۔ بھوک کم ہو جاتی ہے۔ نبض کی رفتار تیز اور بعض اوقات متلی اور تھکی ہو سکتی ہے۔

تشخیص (Diagnosis): یوٹرس سے رطوبتی اخراج کا امتحان کرنا چاہیے۔ پیٹ کا الٹرا سائونڈ کرنا چاہیے۔ پیشاب کا امتحان کرنا چاہیے۔ یوٹرس کی انڈوسکوپ کرنا چاہیے۔ خون کا مکمل معائنہ اور ای، ایس، آر کرنا چاہیے۔

پیچیدگیاں (Complications): اگر سال پن جائی ٹس کا صحیح طور پر علاج نہ کیا جائے تو درج ذیل پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ فیلوپین ٹیوبز سوزش کے نتیجے میں بند ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ بے محل حمل بھی قرار پا سکتا ہے۔ فیلوپین ٹیوبز کی سوزش اووریز تک پھیل سکتی ہے۔ حیض میں بے قاعدگی آسکتی ہے۔ لیکوریائی وجہ سے کمزوری اور کمزوری کی شکایت ہو جاتی ہے۔

علاج (Treatment): سال پن جائی ٹس کی مریضہ کے علاج میں درج ذیل نکات کا خیال رکھنا چاہیے۔ سوزش اور درد دور کرنے والی ادویات دیں۔ مریضہ کو مکمل آرام کا مشورہ دیں۔ زور و ہضم اور متوازن خوراک کے استعمال کا مشورہ دیں۔ حفظانِ صحت کے اصولوں کا خیال رکھنے کا مشورہ دیں۔



فیلولوپین ٹیوب کی سوزش

ہومیوپیتھک علاج: ہیسپر سلف 200 صبح نہادیں۔ سلیشیا 200 رات سوتے وقت دیں۔

فیلولوپین ٹیوب کی سوزش کا انگریزی علاج

➤	Tab Novidat 500mg	1+1 کھانے کے بعد
➤	Tab Danzen D.S	1+1+1 کھانے کے بعد
➤	Tab Buscopan Plus	1+1+1 کھانے کے بعد

دلوای سوزش - دلوائی ٹس (VULVITIS)

عورت کے بیرونی اعضائے تناسل یعنی دلوای سوزش کو دلوائی ٹس کہتے ہیں۔

وجہات (Etiology): دلوائی ٹس درج ذیل وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ فنگل انفکشن خصوصاً کینڈیدا انفکشن کی وجہ سے۔ پیراسائیک انفکشن کی وجہ سے۔ بیکٹیریل انفکشن کی وجہ سے۔ وائرل انفکشن کی وجہ سے۔ کپڑوں سے الرجی کی وجہ سے۔ صابن سے الرجی کی وجہ سے۔ پوڈر سے الرجی کی وجہ سے۔ غیر ضروری بال صاف کرنے والی کریم سے الرجی ہو جائے۔ اینٹی سپینک چیزوں سے الرجی۔ مانع حمل اشیاء سے الرجی۔ دلوای پر اگر چوٹ لگ جائے۔ ویجائنل آلات کے استعمال سے۔ سرویکس کے کینسر کی وجہ سے۔ کیمیکلز کے استعمال سے۔ مختلف ادویات سے الرجی کی وجہ سے۔ دلوای اگر صحیح طور پر صفائی نہ کی جائے۔ لیکوریا کے تیزابی اخراج کی وجہ سے۔ پیشانی راستوں کا انفکشن دلوای سوزش پیدا کر سکتا ہے۔ جماع کی کثرت سے۔ ذیابیطس۔ سوزاک یا سفلس کی وجہ سے بھی دلوای سوزش یعنی دلوائی ٹس کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔

علامات و نشانی (Signs & Symptoms): دلوای میں سوزش ہو جاتی ہے۔ دلوای سرخ ہو جاتی ہے۔ دلوای پر حس ہو جاتی ہے۔ دلوای میں درد ہوتا ہے۔ ویجائنل ڈسچارج ہوتا ہے۔ دلوای میں خارش ہوتی ہے۔ ویجائنہ میں بھی خارش ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات جنگاموں یعنی چڈوں کے لف نوڈز بڑھے ہوئے ہوں گے۔ دلوای کا انفکشن اگر زیادہ ہو تو مریضہ کو بخار ہو سکتا ہے ورنہ عام طور پر بخار نہیں ہوتا۔ دلوای کا یہ انفکشن اندرونی اعضائے تناسل تک بھی پھیل سکتا ہے۔

علاج (Treatment): سوزش دور کرنے والی اور درد کش ادویات دینی چاہئیں۔ دلوای صفائی کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ حفظانِ صحت کے اصولوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔

ہومیوپیتھک علاج: ہائیڈرا سٹس 30+ کریازوٹ 30+ ایپس 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

ولو اکی سوزشس کا انگریزی علاج

➤	Cap Amoxil 500mg	1+1 کھانے کے بعد
➤	Tab T-Day	ایک روزانہ
➤	Tab Danzen D.S	1+1+1 کھانے کے بعد

☆☆☆☆☆☆

عُثْمَانِيَّةٌ بِلِي كِيشَن

دلوای خارش - پرورائی ٹس دلوائی

(PRURITIS VULVAE)

عورتوں کے بیرونی اعضاءے تناسل یعنی ولوایں تحریک اور خارش ہونے کو پرورائی ٹس دلوائی کہتے ہیں۔

وجہات (Etiology): فنکشنل انفیکشن مثلاً کینڈیڈا کا انفیکشن۔ پیراسائیکلک مثلاً ٹرائیکو موناںس و بیجی نیلس کا انفیکشن۔ صابن سے ری ایکشن ہو جانا۔ اینٹی سپٹک کے استعمال سے ری ایکشن ہو جانا۔ ویجاٹل ڈرگز سے ری ایکشن ہو جانا۔ نفع حمل ادویات کا ویجاٹل پر ری ایکشن کرنا۔ صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنا۔ انڈے، مچھلی وغیرہ سے الرجی ہونا۔ جلد کی عام بیماریاں مثلاً ایگزیم، جلد کی سوزش، سورائسز، خارش وغیرہ۔ ذیابیطس کی بیماری کی وجہ سے۔ وٹامنز کی کمی ہونا۔ دلوای بیماریوں کی وجہ سے۔ سن یاس کے بعد ایسٹروجنز ہارمون کی کمی کی وجہ سے۔ ویجاٹل کا سکڑنا۔ دلوای کا انفیکشن ہونا۔ ولوایں السرز ہونا۔ دلوای کے آس پاس کسی جگہ کا انفیکشن ہونا۔

علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms): دلوایں خارش ہوتی ہے۔ دلوای کی یہ خارش آس پاس کے ملحقہ حصوں پر بھی پھیل سکتی ہے۔ ولوایں سوزش ہوتی ہے۔ ولوایں حس ہو جاتی ہے خارش کرنے کی وجہ سے ولوایں درد اور سرخی پیدا ہو جاتی ہے۔ خارش کرنے کی وجہ سے ولوایں جلن ہوتی ہے۔ خارش کی وجہ سے مریضہ کو نیند نہیں آتی ہے۔ خارش کرنے کی وجہ سے ولوایں زخم سے بن جاتے ہیں اگر صحیح طور پر علاج نہ کیا جائے تو دلوای کی یہ خارش انتہائی تکلیف دہ صورت اختیار کر لیتی ہے۔

علاج (Treatment): دلوای خارش کے علاج میں ورج ذیل باتوں کا خیال رکھیں؛

- ◀ الرجی کی صورت میں ان اشیاء سے پرہیز کریں جو کہ خارش کا سبب بنتی ہیں۔
- ◀ دافع خارش ادویات کے استعمال کا مشورہ دیں۔
- ◀ دلوای صفائی و ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔
- ◀ اصل وجہ تلاش کر کے علاج کریں اور حفظان صحت کے اصولوں پر کاربند رہیں۔

ہومیوپیتھک علاج: امبراگریشیا 30 + سلفر 30 + آر سکم 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

ولوا کی حشرات کا انگریزی علاج

➤	Tab Rigix	ایک گولی روزانہ
➤	Canesten Vaginal Cream	روزانہ رات اندام نہانی میں لگائیں
➤	Tab Danzen D.S	1+1+1 کھانے کے بعد

☆☆☆☆☆☆

عُثْمَانِيَّةٌ بِلِي كِيشَن

ویجائنہ کی سوزش - ویجی نائی ٹس (VAGINITIS)

اندام نہانی یعنی ویجائنہ کی سوزش کو ویجی نائی ٹس کہتے ہیں۔

وجہات (Etiology): ویجی نائی ٹس کی درج ذیل وجوہات ہو سکتی ہیں:

شوگر کی بیماری کی وجہ سے۔ ویجائنہ پر چوٹ کا لگنا۔ ویجائنل آلات کے استعمال سے۔ سرویکس کے کینسر کی وجہ سے۔ کیمیکلز کے استعمال سے۔ بیکیٹریل انفیکشن کی وجہ سے۔ وائرل انفیکشن کی وجہ سے۔ پیراسائٹک انفیکشن کی وجہ سے۔ فنگل انفیکشن کی وجہ سے۔ ولوا کی سوزش کی وجہ سے۔ مختلف اشیاء سے الرجبی کی وجہ سے۔ تیزابی لیکوریا کے اخراج کی وجہ سے بھی ویجائنہ کی سوزش ہو سکتی ہے۔

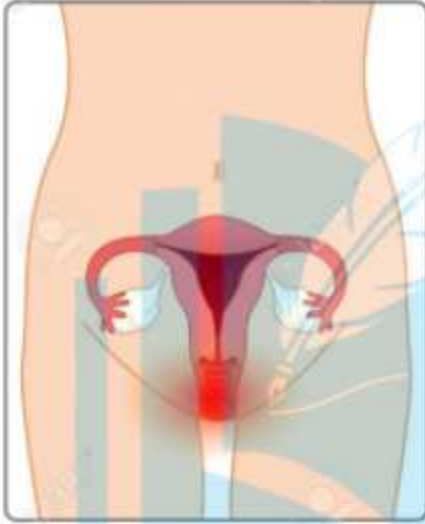
علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms): ویجی نائی ٹس کی مریضہ میں درج ذیل علامات پائی جاسکتی ہیں:

ویجائنہ میں درد ہوتا ہے۔ یہ درد جلن دار ہوا کرتا ہے۔ ویجائنل بلینڈنگ ہو سکتی ہے۔ ویجائنل ڈسچارج ہوا کرتا ہے۔ ویجائنہ سے پیپ کا اخراج بھی ہو سکتا ہے۔ ویجائنہ میں سرخی پائی جاتی ہے۔ ویجائنہ میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ ویجائنہ پر حس ہوتی ہے۔ ویجائنہ میں خارش بھی ہو سکتی ہے۔ عموماً انفیکشن حمل کے دوران زیادہ ہوا کرتا ہے۔

علاج (Treatment): ویجی نائی ٹس کے علاج کے سلسلے میں درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے:

- ◀ دافع درد ادویات کے استعمال کا مشورہ دینا چاہیے۔ دافع سوزش ادویات کے استعمال کا مشورہ دینا چاہیے۔
- ◀ جنسی ملاپ سے کچھ عرصے پرہیز کا مشورہ دینا چاہیے۔
- ◀ مرض کی اصل وجہ تلاش کر کے علاج کرنا چاہیے۔
- ◀ حفظانِ صحت و صفائی کے اصولوں پر کاربند رہنا چاہیے۔

Types Of Vaginitis



Trichomonas



Candida



Atrophic



Bacterial

شرمگاہ یعنی ویجائٹس کی سوزش، ویجیٹائیٹس

ہومیو پیتھک علاج: کینتھرس Q + ہیلوناٹز Q + تھوجا Q ملا کر پندرہ قطرے تین مرتبہ دیں۔

شرمگاہ کی سوزش کا انگریزی علاج

➤	Cap Cefiget 400mg	1+1 کھانے کے بعد
➤	Tab Chymoral Forte	1+1 کھانے کے بعد
➤	Tab Avil 25	ایک گولی روزانہ رات

☆☆☆☆☆☆☆☆

سرویکس کی سوزش - سروی سائی ٹس (CERVICITIS)

یوٹرس کے نچلے حصے سرویکس کی سوزش کو سروی سائی ٹس کہتے ہیں۔

وجوہات (Etiology): اس مرض کی وجوہات درج ذیل ہیں؛

ذیابیطس کی بیماری۔ بچے کی پیدائش کے وقت سرویکس کا زخمی ہونا۔ بیکٹیریل انفیکشن۔ آلات کا استعمال۔ صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنا۔ یوٹرس کی سوزش پھیل کر سرویکس تک جا سکتی ہے۔

علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms): اس مرض میں درج ذیل علامات و نشانیوں ہوتی ہیں؛

سرویکس سے پہلے پہل پتلی رطوبت والا اخراج ہوتا ہے۔ جیسے جیسے سوزش زیادہ ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے سرویکس سے گاڑھی بدبودار پیپ کا اخراج ہوتا ہے۔ سوزش کی وجہ سے متاثرہ حصہ میں درد ہوتا ہے۔ یہ درد تمام پیڑ و تک پھیلا کرتا ہے۔ سرویکس میں سوزش ہوتی ہے۔ سرویکس پر حس ہوتی ہے۔ کمر کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے۔ پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے۔ سرویکس میں جلن ہوتی ہے۔ بعض اوقات سرویکس سے پیپ کا اخراج ہو سکتا ہے۔ حیض کے دوران درد ہوتا ہے۔ حیض میں زیادتی ہوتی ہے۔ جماع کے وقت درد ہوتا ہے۔ مریضہ جماع سے خوفزدہ ہوتی ہے۔ اگر سوزش زیادہ ہو تو بخار ہوتا ہے ورنہ عام حالات میں بخار نہیں ہوتا ہے۔

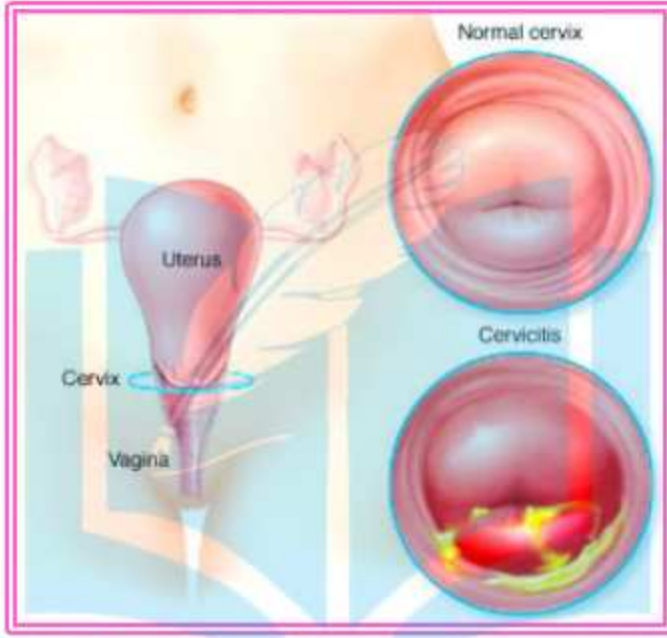
تشخیص (Diagnosis): سرویکس کی سوزش کا علاج درج ذیل اصولوں کے مطابق کرنا چاہیے؛

◀ سرویکس کے اخراج کا لیبارٹری معائنہ کرنا چاہیے۔

◀ الٹراساؤنڈ کرنا چاہیے۔ سرویکس کی انڈوسکوپی کرنی چاہیے۔

◀ پیشاب کا لیبارٹری تجزیہ کرنا چاہیے۔

◀ خون کا مکمل امتحان اور ای، ایس، آر کرنا چاہیے۔



سرویکس کی سوزش، سروی سائیٹس

ہومیوپیتھک علاج: سپیا 30+ سیکیل کار 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

سرویکس کی سوزش کا انگریزی علاج

➤	Cap Ampiclox 500mg	1+1 کھانے کے بعد
➤	Tab Chymotrip Forte	1+1 کھانے کے بعد
➤	Tab Buscopan Plus	1+1 کھانے کے بعد

اینڈومیٹریٹس - اینڈومیٹرائیٹس (ENDOMETRITIS)

بچہ دانی یعنی یوٹرس کی اندرونی تہہ اینڈومیٹریٹس کی سوزش کو اینڈومیٹرائیٹس کہتے ہیں۔

وجہات (Etiology): اس مرض کی وجوہات درج ذیل ہیں:

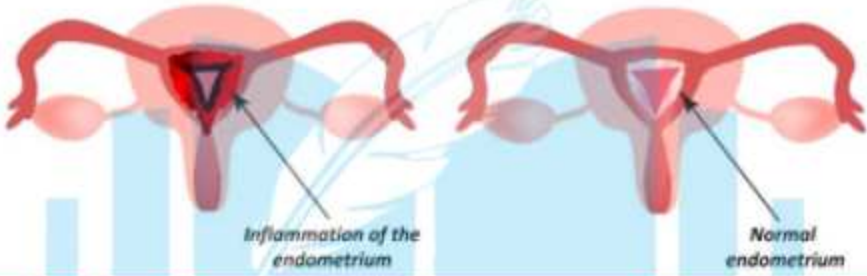
اینڈومیٹریٹس کا انفیکشن۔ فیلوپین ٹیوبز کی سوزش۔ ویجاٹھ کی سوزش۔ سرویکس کی سوزش۔ ولوا کی سوزش۔ سرویکس کا کینسر۔ اینڈومیٹریٹس کا کینسر۔ زچگی کے دوران یوٹرس کا زخمی ہونا۔ مانع حمل ادویات کا استعمال۔ اینڈومیٹریٹس کی ٹی بی ہونا۔ ویجاٹھل معائنہ کے دوران آلات کا استعمال۔ سوزاک کا پھیل جانا۔

علامات و نشانیات (Signs & Symptoms): اس مرض میں درج ذیل علامات و نشانیات ہوتی ہیں:

پیلوس میں درد ہوتا ہے۔ ویجاٹھ سے رطوبت کا اخراج ہوتا ہے۔ ویجاٹھل اخراج میں خون ملا ہوا ہو سکتا ہے۔ کمر درد ہوتا ہے۔ بے قاعدہ اور کثرت سے حیض ہوتا ہے۔ خون کی کمی یعنی انیمیا ہوتا ہے۔ مریضہ میں کمزوری پائی جاتی ہے۔ زیر ناف حصہ انتہائی پر حس ہوتا ہے۔ مریضہ کو بخار ہو جاتا ہے۔ اینڈومیٹریٹس کی یہ سوزش دوسرے حصوں تک پھیل سکتی ہے۔ ویجاٹھ میں جلن ہوتی ہے۔ ویجاٹھ میں خارش ہوتی ہے۔ ویجاٹھ میں درد کی سی کیفیت پائی جاتی ہے۔ مریضہ کو بار بار بارپیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔ مریضہ کی جنسی خواہش میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔

علاج (Treatment): دافع درد ادویات کے استعمال کا مشورہ دینا چاہیے۔ دافع سوزش ادویات کے استعمال کا مشورہ دینا چاہیے۔ مریضہ کو مکمل آرام کا مشورہ دینا چاہیے۔ کچھ عرصہ جماع سے پرہیز کا مشورہ دینا چاہیے۔ حفظان صحت کے اصولوں پر کاربند رہنے کا مشورہ دینا چاہیے۔ مریضہ کو چاہیے کہ اس دوران بوجھ وزن کا کام بالکل نہ کرے۔ کوئی بھاری کام نہ کرے اور روزمرہ کام کے دوران پیروں کے بل نہ بیٹھے۔

Endometritis



بچے دانی کی اندرونی تہہ کی سوزش، اینڈومیٹرائیٹس

ہومیو پیتھک علاج: آر سکیم +30 سپیا +30 سی سیوگا 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

بچے دانی کی سوزش کا انگریزی علاج

➤	Tab Tarivid 200mg	1+1 کھانے کے بعد
➤	Tab Chymoral Forte	1+1 کھانے کے بعد
➤	Tab Dicloran 50mg	1+1 کھانے کے بعد



سیلان الرحم - لیکوریا

(LEUCORRHOEA)

ویجائنہ یعنی شرم گاہ سے سفید رنگ کی رطوبت کا اخراج لیکوریا کہلاتا ہے۔

وجوہات (Etiology): لیکوریا کے مرض کی وجوہات درج ذیل ہیں؛

حمل۔ جنسی تحریک۔ سرویکس کے ٹشوز کا جھڑنا۔ ویجائنل معائنہ کے دوران آلات کا استعمال۔ یوٹرس کا ٹل جانا۔ ویجائنل انفیکشن خصوصاً ٹرائیکو موناںس و بیجی نیلس یا کینڈیڈا کا انفیکشن۔ یوٹرس کا کینسر۔ سرویکس کا کینسر۔ خواتین کے اعضائے مخصوصہ کے اندرونی حصوں کی سوزش۔ خواتین کے اعضائے مخصوصہ میں اندرونی طور پر زخم یا چوٹ لگنے سے بھی لیکوریا کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔

علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms): لیکوریا کے مرض میں درج ذیل علامات اور نشانیاں ملتی ہیں؛

ویجائنہ سے سفید رنگ کی رطوبت کا اخراج ہوتا ہے۔ عورتیں خوفزدہ ہوتی ہیں کہ انہیں اعضائے مخصوصہ کا کینسر تو نہیں ہو گیا۔ ویجائنل اخراج خراش دار بھی ہو سکتا ہے۔ ویجائنل اخراج کپڑوں پر داغ دھبے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ پیلووس میں درد ہوتا ہے۔ مریضہ میں کمر درد ہوتا ہے۔ مریضہ میں کمزوری پائی جاتی ہے۔ مریضہ کے تمام جسم میں دریں اور سستی پائی جاتی ہیں۔ پیٹرو میں بھی درد ہوتا ہے۔ بھوک میں کمی، رنگت پیلی اور بعض اوقات بخار بھی ہو جاتا ہے۔

تشخیص (Diagnosis): ویجائنل رطوبت کا لیبارٹری امتحان کرنا چاہیے۔ پیلوک الٹراساؤنڈ کرنا چاہیے۔ ویجائنل معائنہ کرنا چاہیے۔ پیشاب کا عام امتحان کرنا چاہیے۔ خون کا مکمل امتحان اور ایس، آئر کرنا چاہیے۔

علاج (Treatment): دافع درد اور دافع سوزش ادویات دینی چاہئیں۔ مریضہ کو مکمل آرام اور حفظانِ صحت کے اصولوں پر کاربند رہنے کا مشورہ دیں۔ متوازن، سادہ خوراک کے استعمال کا مشورہ دیں۔

ہومیوپیتھک علاج: الیومینا 30+ سپیا 30+ پلسٹلا 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

لیکوریٹا کا انگریزی علاج

➤	Tab Flagyl 400mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➤	Cap Vibramycin 100mg	ایک روزانہ کھانے کے بعد
➤	Cap Diflucan 150mg	صرف ایک کیپسول ہی استعمال کریں

☆☆☆☆☆☆

عُثْمَانِيَّةٌ بِلِي كِيشَن

سوزاک - گنوریا

(GONORRHOEA)

گنوریا ایک جنسی مرض ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو جنسی ذریعے سے منتقل ہو سکتی ہے۔

وجہات (Etiology): گنوریا کا مرض ایک خاص قسم کے جراثیم گونو کوکس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جراثیم متاثرہ مرد یا عورت سے جنسی تعلق قائم کرنے سے دوسرے میں پھیلتا ہے۔ کئی مرتبہ مریضہ میں انفیکشن ہونے کے باوجود کوئی خاص علامات رونما نہیں ہوتیں۔

علامات و نشانی (Signs & Symptoms): گنوریا میں درج ذیل علامات پائی جاتی ہیں: پیشاب کی نالی یوریتھرا میں سوزش ہو جاتی ہے۔ پیشاب کرتے ہوئے مریضہ کو جلن محسوس ہوتی ہے۔ پیشاب کی نالی یوریتھرا میں درد بھی محسوس ہوتا ہے۔ یوریتھرا سے بدبودار جلن والی رطوبت خارج ہوتی ہے۔ یوریتھرا سے خارج ہونے والی رطوبت اگر کپڑوں پر لگ جائے تو دھبہ ڈال دیتی ہے۔ ویجائٹ میں سوزش ہو جاتی ہے۔ ویجائٹ میں جلن اور درد ہوتا ہے۔ پیشاب کے راستے سفید گاڑھی پیپ کا اخراج ہوتا ہے۔ ویجائٹ سے لیکور یا بھی جاری ہو جاتا ہے۔ اگر انفیکشن پھیل جائے تو سروس، یوٹرس اور فیلوپین ٹیوبز کو بھی متاثر کرتا ہے۔ مریضہ پیڑ و میں درد محسوس کرتی ہے۔ کمر میں بھی درد ہوتا ہے۔ کمر اور پیڑ و میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ سوزاک میں مبتلا مریضہ اگر حاملہ ہو تو مس کیرج بھی ہو سکتا ہے۔ سوزاک میں مبتلا زچہ کے نومولود بچے کی آنکھوں میں سوزش ہو جاتی ہے۔

تشخیص (Diagnosis): یوریتھرا یا ویجائٹل ڈسچارج میں خوردبین کے ذریعے گونو کوکس جراثیم کی موجودگی کنفرم کر کے مرض کی تشخیص کی جاسکتی ہے۔ خون کا مکمل معائنہ اور ای، ایس آر کرنا چاہیے۔ پیشاب کا عام امتحان کرنا چاہیے۔ مرض کے ٹھیک ہونے تک جماع سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔

ہو میو پیٹھک علاج: کینا بس سٹائو 30 + کینتھر س 30 + تھو جا 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں

سوزاک کا انگریزی علاج

➤	Cap Vibramycin 100mg	ایک روزانہ کھانے کے بعد
➤	Tab Ciproxin 500mg	1+1 کھانے کے بعد
➤	Tab Voren 50mg	1+1 کھانے کے بعد

☆☆☆☆☆☆☆☆

عُثْمَانِيَّة سِلِي كِيشَن

آتشک - سفلس

(SYPHILIS)

سفلس یعنی آتشک ایک جنسی بیماری ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہو سکتی ہے یہ بیماری پیدائشی بھی ہو سکتی ہے۔

وجوہات (Etiology): سفلس کا مرض ایک خاص جراثیم ٹریپو نیما پیلی ڈیم کے ذریعے لگا کرتا ہے۔ یہ جراثیم متاثرہ فرد سے جنسی میل جول کے ذریعے دوسرے فرد میں داخل ہو کر بیماری پیدا کرنے کا باعث بنا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر سفلس سے متاثرہ مریض کا خون کسی دوسرے صحت مند فرد کو چڑھادیا جائے تو وہ بھی اس مرض کا شکار ہو سکتا ہے۔ سفلس کے مرض کے تین درجے ہوتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں:

سفلس کی پہلی سیج: اعضائے تناسل و مخصوصہ کی جلد کی ہلکی سی خراش کے ذریعے سفلس کے جراثیم تقریباً تین سے چھ ہفتوں کے بعد ایک ہلکا سا زخم پیدا کر دیتے ہیں جسے شکر کہتے ہیں۔ شکر سے پانی کی طرح کا ڈسچارج ہوا کرتا ہے جس میں سے بعد میں پیپ بھی خارج ہوا کرتی ہے۔ متاثرہ جلد پر ورم آ جاتا ہے اور وہ جگہ سخت ہو جایا کرتی ہے۔ اس کے ایک ہفتے کے بعد متعلقہ لف نوڈز پھول کر بڑھ جایا کرتے ہیں تاہم ان میں درد نہیں ہوا کرتا۔ سفلس کے یہ شکر عام طور پر ویجائٹ، لیبیا مائینورا، لیبیا میجورا، یوریتھرایا پھر سرویکس کے اندرونی حصوں پر ہوتے ہیں۔

سفلس کی دوسری سیج: سفلس کا شکر ایک سے آٹھ ہفتوں میں خود بخود غائب ہو جایا کرتا ہے۔ سفلس کے جراثیم مریضہ کے خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور جلد پر ابھار سے نکل آتے ہیں جن میں خارش نہیں ہوتی۔ مریضہ کو بھوک نہیں لگتی۔ جسمانی کمزوری اور تھکن ہو جاتی ہے۔ انیمیا، بخار، جسم درد، سر درد ہوتا ہے۔ سر کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ منہ میں چھالے ظاہر ہوتے ہیں اور گلہ پک جاتا ہے۔ آنکھوں کے پردہ بصارت کا رنیا اور آئرس کی سوزش ہو جاتی ہے جبکہ ویجائٹ اور مقعد پر سخت سے گومز کنڈائی لو میٹابن جاتے ہیں

سفلس کی تیسری سٹیج: اس سٹیج میں سفلس کے جراثیم ہڈیوں، جوڑ، آنکھوں خون کی نالیوں اور دل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس مرحلے میں جسم میں سخت اور لچک دار گومز جیسے ابھار پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں Gummas کہا جاتا ہے۔ یہ گومز جسم میں کسی بھی جگہ بن سکتے ہیں۔ اس سٹیج میں جلد کا سُن ہونا۔ ناک کا بیٹھنا۔ تالو میں سوراخ ہونا۔ بلڈویسلز کا تنگ ہونا۔ دماغ و حرام مغز کی جھلیوں کی سوزش کے نتیجے میں فالج ہونا یا پاگل پن اور ہڈیان کی علامات کا ظاہر ہونا سامنے آتا ہے۔

تشخیص (Diagnosis): اگر مریضہ پر سفلس کا شک ہو تو درج ذیل ٹیسٹوں کے ذریعے تشخیص کو کنفرم کرنا چاہیے اور مناسب علاج کرنا چاہیے۔ سفلس کے شکرز سے خارج ہونیوالی رطوبت کا لیبارٹری تجزیہ کرنا چاہیے۔ وی، ڈی، آر، ایل (V.D.R.L) ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ فلوریسنٹ ٹریپو نیمل اینٹی باڈیز ایب زارپشن ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ بلڈ کلچر ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ خون کا مکمل امتحان اور ای ایس آر کرنا چاہیے۔ پیشاب کا عام امتحان کرنا چاہیے۔ مریضہ کا علاج کسی ماہر معالج سے کرانا چاہیے۔

ہومیوپیتھک علاج: مر کسال 30 + نائٹرک ایسڈ 30 + تھو جا 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

آٹنک کا انگریزی علاج

➤	Cap Vibramycin 100mg	1+1 کھانے کے بعد
➤	Tab Danzen D.S	1+1 کھانے کے بعد

☆☆☆☆☆☆☆☆

رحم کے ٹیومرز - یوٹرائن ٹیومرز

(UTERINE TUMOURS / FIBROIDS)

یوٹرائن ٹیومر سے مراد یوٹرس میں ٹیومر کا موجود ہونا ہے جسے فائبرائیڈ بھی کہتے ہیں۔

ٹیومرز کی اقسام (Types): یوٹرائن ٹیومرز کی دو اقسام ہو سکتی ہیں:

- 1- یوٹرس کابی نائن ٹیومر: جو کہ ایک نہ پھیلنے والا کم خطرناک ٹیومر ہوتا ہے۔
- 2- یوٹرس کاسیلیگنٹ ٹیومر: جو کہ ایک پھیلنے والا خطرناک ٹیومر ہوتا ہے۔

وجہات (Etiology): ابھی تک یوٹرس میں ٹیومرز پیدا ہونے کی کوئی صحیح وجہ معلوم نہیں کی جاسکی

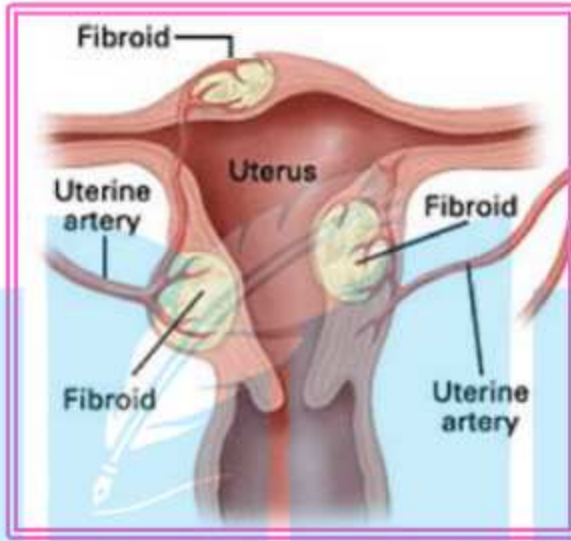
ہے۔ پچیس سال سے کم عمر خواتین میں بہت ہی کم ہوتا ہے۔ ان خواتین میں یہ ٹیومرز زیادہ ہوتا ہے جو کہ شادی کے بعد حاملہ نہیں ہوئی ہوتیں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ یوٹرائن ٹیومر ٹیگر و عورتوں میں زیادہ عام ہوتا ہے۔ شادی شدہ عورتوں میں کثرت جماع سے۔ پیلووس میں پرانی سوزش کی وجہ سے۔ زنانہ اعضائے تناسل میں زخم کی وجہ سے۔ ہارمونل ادویات کے زیادہ استعمال کی وجہ سے بھی یوٹرائن ٹیومرز پیدا ہو سکتے ہیں۔

علامات و نشانی (Signs & Symptoms): پیٹ میں ورم آ جاتا ہے۔ پیلووس میں

وزن کا احساس۔ پیلووس میں ہلکا ہلکا درد ہوتا ہے۔ حیض بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پیشاب بار بار اور زیادہ آتا ہے بعض اوقات پیشاب رک بھی سکتا ہے۔ پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ پیلووس میں ٹٹول کر دیکھنے سے حجم سا محسوس ہوتا ہے۔ سرویکس میں حجم سا محسوس ہوتا ہے۔ پیلووس پر حس ہوگا۔ لیکور یا ہوتا ہے۔ یوٹرس سے جریان خون ہوتا ہے۔ کمزور ہوتا ہے۔ جریان خون کی وجہ سے اینیمیا ہوتا ہے۔ مریض دن بدن کمزور ہوتی جاتی ہے۔

تشخیص (Diagnosis): پیلوک الٹراساؤنڈ۔ پیلوک ایکس رے۔ ہسٹرو سالیپینگو گرافی۔ لیپراسکوپي۔

بائیوپسی۔ پیشاب کا عام امتحان۔ خون کا مکمل معائنہ اور ای، ایس، آر، ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں۔



بچہ دانی کے ٹیومرز، یوٹرائن فائبرائیڈز

ہومیوپیتھک علاج: کلکیریا یا ٹیوڈائڈ 30 + کوئم 30 + تھوجا 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

رحم کے ٹیومرز کا انگریزی علاج

➤	Cap Brino 500mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➤	Cap Vio-Vioptal	ایک روزانہ استعمال کریں
➤	Tab Ponstan Forte 500mg	1+1+1 کھانے کے بعد

نوٹ: یوٹریس کے فائبرائیڈز کا حتمی علاج بہر حال سرجری ہے جس کے لئے کسی سرجن سے مشورہ کریں۔

☆☆☆☆☆☆

سرویکس کا کینسر۔ کاری نوما سرویکس

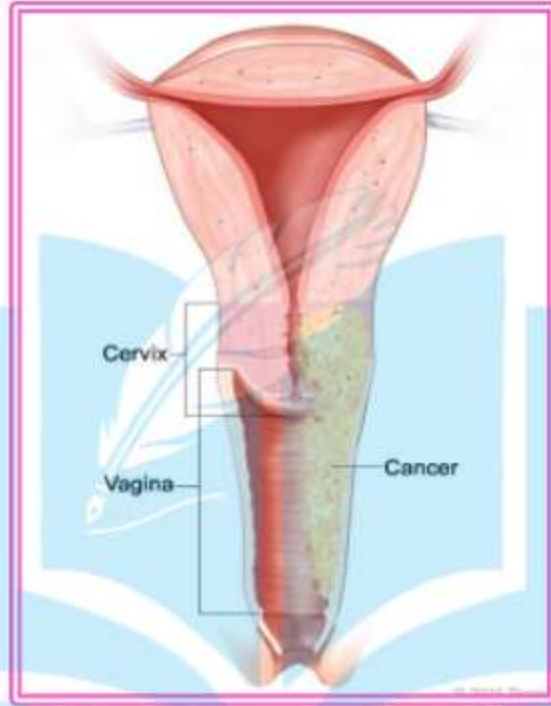
(CARCINOMA CERVIX)

بچے دانی کے منہ یعنی سرویکس کا پھیلنے والا کینسر کاری نوما سرویکس کہلاتا ہے۔

وجہات (Etiology): کاری نوما سرویکس کی ابھی تک کوئی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ کاری نوما سرویکس ایسی خواتین کو عموماً ہوتا ہے جن کی شادی جلدی ہو جاتی ہے۔ کثرت مباشرت کے باعث بھی سرویکس کا کینسر ہو سکتا ہے۔ ایسی عورتوں کو بھی عموماً ہوتا ہے جن کے بہت زیادہ جنسی تعلقات ہوں۔ ہرپیز وائرس ٹائپ II کی وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ سرویکس کا کینسر عموماً پینتالیس سے پچپن سال کی عمر کے درمیان ہوتا ہے۔

علامات و نشانی (Signs & Symptoms): ویجائنہ سے بے قاعدہ جریان خون ہوتا ہے۔ ویجائنہ میں زخم ہو جاتے ہیں۔ ویجائنہ سے بدبودار رطوبتی اخراج ہوتا ہے۔ پیلووس میں درد ہوتا ہے۔ پیشاب کی تکالیف ہوتی ہیں۔ کاری نوما سرویکس گردوں تک پھیل کر گردے فیل کر نیکا باعث بن سکتا ہے۔ مریضہ انیمیا کا شکار ہوگی۔ سرویکس کی جگہ پر زخم ہوں گے۔ مریضہ حد درجہ کمزور ہوگی۔ مریضہ کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے۔ سرویکس پر حس ہو جاتا ہے۔ کسی بھی آلے سے اگر سرویکس کو چھوا جائے تو سرویکس سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر مریضہ کے ریکٹم میں انگلیاں ڈال کر سرویکس کو محسوس کیا جائے تو وہاں پر حجم سا محسوس ہوتا ہے۔ زیادہ ویجائنل بلیڈنگ کی وجہ سے مریضہ خوف میں مبتلا ہو جاتی ہے مریضہ ذہنی طور پر چڑچڑی ہوگی اور کمزور ہوتا ہے۔

تشخیص (Diagnosis): پیلوک الٹراساؤنڈ۔ بائیوپسی۔ ویجائنہ کے رطوبتی اخراج کا خوردبینی معائنہ کرنا چاہیے۔ پیشاب کا عام امتحان۔ خون کا مکمل معائنہ اور ایس، آر ٹیسٹ کرنا چاہیے۔



سروریکس کا کینسر، کاری نو ماسرویکس

ہومیوپیتھک علاج: کالی سائی انیم 30 + پلسٹلا 30 + ہوانگ نان 30 ملا کر تین مرتبہ دیں۔

سروریکس کے کینسر کا انگریزی علاج

➤	Tab Tramal SR 50mg	1+1 کھانے کے بعد
➤	Tab Sangobion	ایک روزانہ استعمال کریں
➤	Cap Transamin 500mg	1+1+1 کھانے کے بعد

نوٹ: سروریکس کے کینسر کے علاج کے سلسلے میں کسی ماہر امراض سرطان یعنی آنکالوجسٹ سے مشورہ کریں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

بچے دانی کا کینسر - کارسی نوما یوٹرس

(CARCINOMA UTERUS)

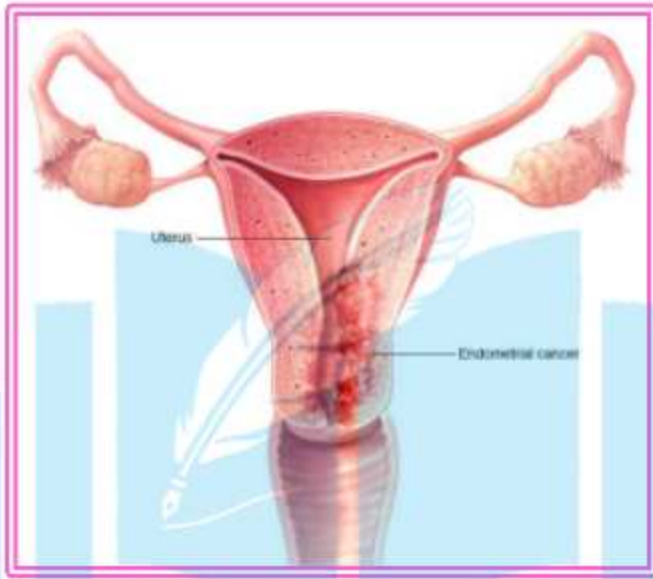
یوٹرس کی اندرونی تہہ اینڈومیٹریئم کے پھیلنے والے کینسر کو کارسی نوما یوٹرس کہتے ہیں۔

وجہات (Etiology): سن یاس کا دیر سے شروع ہونا۔ عام طور پر یہ مرض سن یاس کے بعد ہوتا ہے ذیابیطس کی بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ گلوکوز کے بے قاعدہ میٹابولزم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ مونوپا بھی اس مرض کی ایک اہم وجہ ہے۔ اینڈومیٹریئم کا ہائپرپلازیا۔ خون حیض کی بے قاعدگی اور شدید اخراج۔ سن یاس کے بعد خون کا جاری ہونا۔ اینڈومیٹریئم کی پرانی سوزش۔ اینڈومیٹریئم میں پاپلیس ہونا۔ اینڈومیٹریئم میں فائبرائڈ ہونا۔ لیکوریہ کا ہونا بھی اس مرض کی وجہات ہیں۔

علامات و نشانی (Signs & Symptoms): سن یاس کے بعد خون حیض کا بے قاعدہ اخراج۔ لیکوریہ۔ حیض کے دنوں میں خون کا شدید بے قاعدہ اخراج۔ پیلووس میں بوجھ کا احساس۔ کمر میں درد۔ شدید اخراج خون۔ انیمیا۔ رحم کا سائز میں بڑھ جانا۔ مریضہ کی رنگ پیلی پڑ جانا اور مریضہ میں کمزوری کا حد درجہ احساس پایا جاتا ہے۔

تشخیص (Diagnosis): اس مرض کی تشخیص کے لئے درج ذیل ٹیسٹ کرنے چاہئیں:

- ◀ پیلوک الٹراساؤنڈ۔
- ◀ پیلوک ایکسری۔
- ◀ اینڈومیٹریئل بائیوپسی۔
- ◀ پیشاب کا عام امتحان۔
- ◀ خون کا مکمل معائنہ۔
- ◀ ای۔ ایس، آر ٹیسٹ۔



بچے دانی کا کینسر، کارسی نو مایوٹرس

ہومیوپیتھک علاج: کانڈورگو 30 + ہائیڈرا سنس 30 + سیکیل کار 30 ملا کر تین مرتبہ دیں۔

بچے دانی کے کینسر کا انگریزی علاج

➤	Tab Naprosyn 250mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➤	Cap Transamin 500mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➤	Tab Theragran-H	ایک روزانہ استعمال کریں

نوٹ: یوٹرس کے کینسر کے علاج کے سلسلے میں کسی ماہر امراض سرطان یعنی آنکالوجسٹ سے مشورہ کریں۔

پستان کی سوزش - ماسٹائیٹس (MASTITIS)

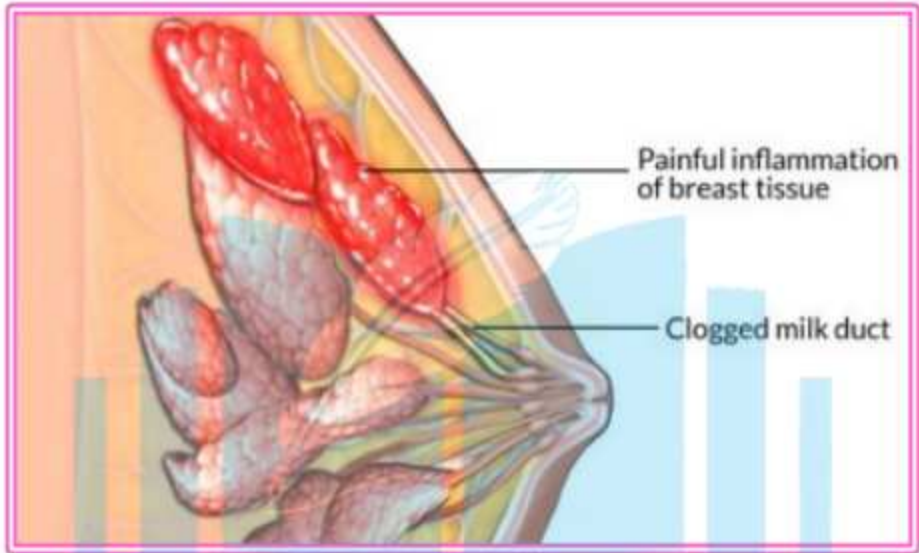
پستان میں سوزش ہو جانے کو ماسٹائیٹس کہتے ہیں۔ پستان کی سوزش دودھ پلانے والی ماؤں میں عام طور پر پائی جاتی ہے۔

وجوہات (Etiology): پستان پر چوٹ کا لگنا۔ پستان میں انفیکشن ہو جانا۔ پستان کے آس پاس کی جگہوں پر انفیکشن ہونا۔ پستان سے دودھ کے اخراج میں رکاوٹ پیدا ہونا۔ نپل میں زخم ہونا عام طور پر خواتین میں پستان کی سوزش کا باعث بن سکتا ہے۔

علامات و نشانی (Signs & Symptoms): پستان میں درد ہوتا ہے۔ پستان میں سوزش ہوتی ہے۔ پستان میں سرخی پائی جاتی ہے۔ پستان پر حس ہوتا ہے۔ پستان اپنے افعال صحیح طور پر سرانجام نہیں دے سکتا۔ مریضہ چلتے ہوئے ہاتھ سے متاثرہ پستان کو سہارا دیتی ہے۔ مریضہ کو 104 سے 105 ڈگری فارن ہائیٹ ٹمپریچر ہوتا ہے۔ متاثرہ پستان کی جانب کے ہاتھ میں بھی درد ہوتا ہے۔ متاثرہ پستان کے سائڈ والی بغل کے لف نوڈز میں سوزش ہو جاتی ہے۔ اگر انفیکشن بڑھ جائے تو پستان میں گلیٹیاں سی بن جاتی ہیں جو اکثر اوقات درد اور جلن کرتی ہیں۔

علاج (Treatment): پستان کی سوزش کا علاج درج ذیل اصولوں کے تحت کرنا چاہیے:

- ◀ دافع سوزش ادویات دیں۔
- ◀ دافع درد ادویات دیں۔
- ◀ دافع بخار ادویات دیں۔
- ◀ پستان کی صفائی ستھرائی اور حفظان صحت کے اصولوں کا خاص خیال رکھیں۔



عورتوں میں پستان کی سوزش، ماس ٹائیٹس

ہومیوپیتھک علاج: ہیلاڈونا 30+ برائی او نیا 30+ کو نیم 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

پستان کی سوزش کا انگریزی علاج

➤	Cap Lincocin 500mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➤	Tab Danzen D.S	1+1+1 کھانے کے بعد
➤	Tab Revital-B	ایک روزانہ کھانے کے بعد

☆☆☆☆☆☆☆☆

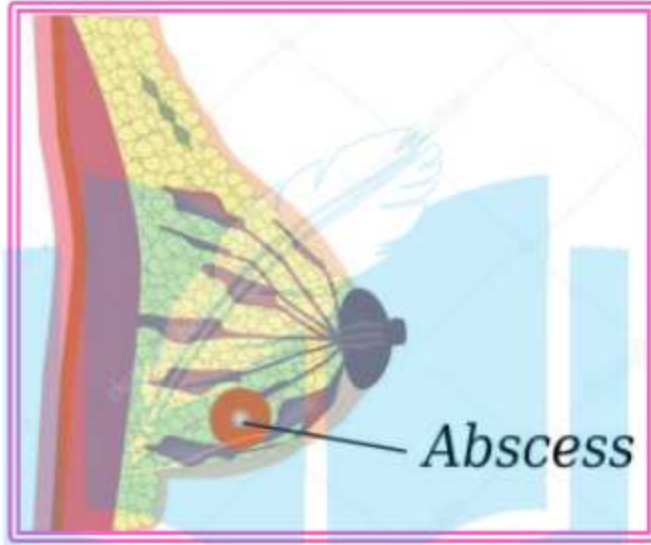
پستان کا پھوڑا - بریسٹ ایبسس (BREAST ABSCESS)

پستان میں پھوڑا بن جانے کو بریسٹ ایبسس کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر پستان کی سوزش کے بعد ہوا کرتا ہے۔
وجوہات (Etiology): پستان پر چوٹ لگنا۔ پستان سے دودھ نکلنے کے راستوں میں رکاوٹ پیدا ہونا۔
 خون میں بیکٹیریا کی زیادتی۔ نامعلوم وجوہات کی بناء پر بھی پستان میں پھوڑا بن سکتا ہے۔ پستان کی پرانی سوزش
 بھی اس کا سبب بن سکتی ہے۔

علامات و نشانی (Signs & Symptoms): پستان میں درد ہوگا۔ پستان میں سوزش
 ہوگی۔ پستان میں سرخی ہوگی۔ پستان گرم ہوگا۔ پستان میں گرمی کا احساس ہوگا۔ پستان اپنا فعل صحیح انجام
 نہیں دے سکتا۔ پستان سے پیپ کا اخراج بھی ہو سکتا ہے۔ پستان سے خون کا اخراج بھی ہو سکتا ہے۔ بعض
 اوقات پستان کے آس پاس کے لف نوڈز بڑھ جاتے ہیں۔ مریضہ کو تیز بخار ہو جاتا ہے۔ پستان میں جلن کا
 احساس ہوگا۔ پستان پر حس ہوگا۔

علاج (Treatment): بریسٹ ایبسس کا علاج درج ذیل اصولوں کے مطابق کرنا چاہیے؛

- ◀ دافع سوزش ادویات دیں۔
- ◀ دافع درد ادویات دیں۔
- ◀ دافع بخار ادویات دیں۔
- ◀ پستان کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔
- ◀ گرم موسم اور گرم ماحول سے پرہیز کرنا چاہیے۔
- ◀ متاثرہ پستان کو بار بار ہاتھ سے دبا کر نہیں دیکھنا چاہیے۔
- ◀ اگر ادویات رزلٹ نہ دیں تو کیس سرجن کو ریفر کرنا چاہیے۔



پستان کا پھوڑا، بریسٹ ایب سس

ہومیوپیتھک علاج: ہیپر سلف 200 + کالی سلف 200 + سلیشیا 200 ملا کر دن میں دو مرتبہ دیں

پستان کے پھوڑے کا انگریزی علاج

➤	Cap Lincocin 500mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➤	Tab Dolor D.S	1+1+1 کھانے کے بعد
➤	Tab Chymotrip Forte	1+1+1 کھانے کے بعد

☆☆☆☆☆☆☆☆

پستان کا کینسر - کاری نو مابریسٹ (CARCINOMA BREAST)

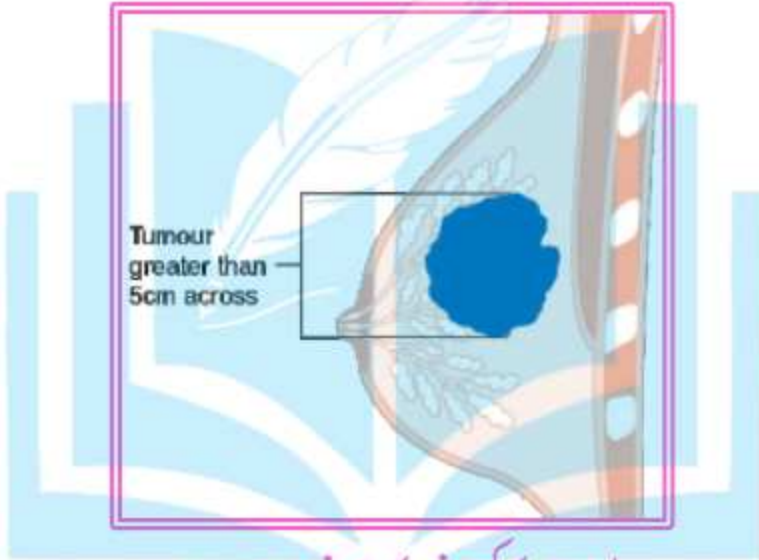
پستان میں پھیلنے والے کینسر کا پایا جانا کاری نو مابریسٹ کہلاتا ہے۔

وجوہات (Etiology): کاری نو مابریسٹ عموماً بوڑھی عورتوں میں پایا جاتا ہے لیکن جوان عورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مرض اولاد والی عورتوں کی نسبت بے اولاد عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح مغربی عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے جبکہ مشرقی عورتوں میں نسبتاً کم پایا جاتا ہے۔ ایسی عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے جو بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتیں۔ یہ کینسر اکثر ایک ہی خاندان کی عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ عورتوں میں ایسٹروجنز اور پروجیسٹرون ہارمونز کا غیر متوازن ہونا بھی اس مرض کا سبب بنتا ہے۔ بعض اوقات بریسٹ کینسر کی کوئی وجہ سامنے نہیں آتی۔ پستان کے کینسر کی وجوہات موروثی طور پر بھی پائی جاسکتی ہیں۔

علامات و نشانی (Signs & Symptoms): مریضہ کو عام طور پر سب سے پہلے چھاتی میں گٹھی کی شکایت پیدا ہوتی ہے۔ شروع شروع میں اس گٹھی میں کوئی درد نہیں ہوتا۔ مریضہ گٹھی والے حصے میں کچھ بے چینی محسوس کرتی ہے بعض اوقات مریضہ کانپل چھاتی میں پیچھے کی جانب کھینچ جاتا ہے۔ نپل کا اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہوتا۔ نپل کی ظاہری شکل و صورت میں تبدیلی۔ متاثرہ پستان کی ظاہری شکل و صورت میں تبدیلی۔ پستان کی گٹھی میں درد ہونا۔ بغلوں میں لفف نوڈز کا سوزش اختیار کرنا پستان کے کینسر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ کینسر سارے جسم میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، پہلے یہ چھاتی میں پھیلتا ہے اس کے بعد آس پاس کے عضلات میں پھیلتا ہے اور پھر کینسر کے سیلز لف و سیلز کے ذریعے جسم میں دور دراز حصوں تک پھیل جاتے ہیں۔ کینسر کے سیلز بذریعہ خون پیٹ، گردن، جسم میں موجود لفف گینڈز، پھیپھڑوں، جگر، دماغ اور کئی دوسری جگہوں تک پھیل جاتے ہیں۔

تشخیص (Diagnosis): میمو گرافی۔ سینہ کا ایکسرے۔ بائیوپسی۔ پیشاب کا عام امتحان۔ خون کا مکمل معائنہ اور ای، ایس، آر ٹیسٹ اس مرض کی تشخیص کے لئے سودمند ثابت ہوتے ہیں۔

علاج (Treatment): ادویاتی علاج کے ساتھ ساتھ سرجیکل علاج کی نہایت اہمیت ہے۔ سرجری کے ذریعے متاثرہ پستان اور لفٹ نوڈز کو نکال دیا جاتا ہے۔ ریڈیائی علاج بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے بہر حال پستان کے کیئر کا شک ہونے پر فوری طور پر کسی قابل اور مستند لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔



پستان کا کیئر، کاری نو ماہر یسٹ

ہومیوپیتھک علاج: کاربوائینی میلس 30+ ہائیڈراسٹس 30+ کوئیم 30 دن میں تین مرتبہ دیں۔

پستان کے کیئر کا انگریزی علاج

➤	Tab Augmentin 625mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➤	Tab Mefnac D.S	1+1+1 کھانے کے بعد
➤	Tab Surbex-Z	ایک روزانہ کھانے کے بعد

نوٹ: پستان کے کیئر کے علاج کے سلسلے میں کسی ماہر امراض سرطان یعنی آنکالوجسٹ سے مشورہ کریں۔

رضاعت اور پستانوں میں دودھ کی کمی

(LACTATION & SUPPRESSED MILK)

رضاعت (Lactation) سے مراد ماں کا اپنے نومولود بچے کو اپنا دودھ پلانا ہے۔ رضاعت کا یہ عرصہ پیدائش سے لے کر دو سال تک ہوتا ہے یعنی ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو اپنی چھاتیوں سے بچے کے دو سال ہونے تک دودھ پلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ کو بچے کیلئے ایک مکمل غذا بنایا ہے اسلئے نومولود بچے کی پیدائش سے لیکر چار ماہ تک دودھ کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں کھلانی چاہیے۔ شروع شروع میں چونکہ ماں کا دودھ گاڑھا ہوتا ہے اس لئے اس میں روغنیات زیادہ ہوتی ہیں جو بچے کے پیٹ میں پہنچ کر جلاب کا کام دیتی ہیں اس طرح بچے کا پیٹ اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ ایسے بچے جو ماں کا دودھ پیتے ہیں ان میں مختلف بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ مختلف بیماریوں کا بہت کم شکار ہوتے ہیں۔ ان کا ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے اور وہ قے اور اسہال کے امراض سے بڑی حد تک بچے رہتے ہیں۔



بچے کو دودھ پلانے کی درست تکنیک

زچہ کے پستانوں میں دودھ کی کمی ہونا: بچے کی پیدائش کے بعد کئی زچہ عورتوں کی چھاتیوں میں بعض اوقات دودھ اتنا پیدا نہیں ہوتا جس سے بچے کی پرورش ہو سکے۔ یہ مرض پہلے سے کچھ جسمانی بیماریوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ مریضہ میں خون کی کمی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے اور عام جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ مختلف قسم کا جریان خون ہو جائے تو بھی مریضہ میں دودھ کی کمی ہو سکتی ہے۔ اسہال اور قے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے زچہ میں دودھ کی کمی ہو سکتی ہے۔ لیکوریا اور دوسرے متعدی امراض کا شکار عورتوں میں دودھ کی کمی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دودھ پر ایک بے نالی غدود پچوٹری گلینڈ کی سکریشن کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس سکریشن کو پرولیکٹن ہارمون کہتے ہیں۔ اگر اس کے اخراج میں کمی ہو تو زچہ میں دودھ کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس مرض کی تشخیص کے لئے عام طور پر کلیئکل ہسٹری ہی کافی رہتی ہے لیکن چند کیسوں میں پرولیکٹن ہارمون کی جانچ کرنی پڑتی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: سیبل سیرولینا Q کے پندرہ قطرے دن میں تین مرتبہ دیں۔

پستانوں میں دودھ کی کمی کا انگریزی علاج

➤	Tab DeCalc Plus	1+1+1 کھانے کے بعد چوسیں
➤	Tab Hilecta	ایک روزانہ کھانے کے بعد
➤	Tab Kak-D	ایک روزانہ کھانے کے بعد

☆☆☆☆☆☆☆☆

حمل کے نفسیاتی وجہ بابتی پہلو

(EMOTIONAL ASPECTS OF PREGNANCY)

انفرائش نسل کا جاری رہنا جملہ ذی حیات مخلوقات میں ایک قدرتی اور طبعی عمل ہے۔ اسی طرح نسل انسانی میں بھی عورتوں کو شادی کے بعد حمل قرار پانا ایک طبعی اور قدرتی عمل ہی ہوتا ہے لیکن اسکے باوجود عورت کو نہ صرف پہلی مرتبہ بلکہ بعد ازاں بھی ہر بار حمل قرار پانے پر مختلف اقسام کے جذباتی اور نفسیاتی مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے جو زیادہ تر مندرجہ ذیل ہوتے ہیں۔ جسمانی افعال میں جو گونا گوں تبدیلیاں ظہور میں آتی ہیں وہ درج ذیل ہیں:

علامات و نشانی (Signs & Symptoms): جی متلانا۔ قے ہونا۔ بھوک کی کیفیت کا بدل جانا یعنی کئی ایک اچھی غذاؤں سے نفرت ہو جانا اور کئی ایک ناقص اور مضر اشیاء مثلاً گاجی اور مٹی وغیرہ کھانے کی رغبت پیدا ہو جانا۔ پیشاب کا بار بار آنا۔ قبض یا بواسیر کی شکایت کا لاحق ہونا وغیرہ۔ ان کی بناء پر ایک عام ذکی الحس قسم کی عورت حمل کو بھی ایک مرضیاتی کیفیت تصور کرتے ہوئے غمزہ ملول اور بے چین رہنے لگتی ہے۔ اس میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ بات بات پر خفگی کا اظہار کرنے لگتی ہے حالانکہ درج بالا جملہ کیفیات کو معمول کے مطابق معمولی اور طبعی مظاہر تصور کرتے ہوئے ان کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے تو جملہ تکالیف کا احساس کافی حد تک کم ہو سکتا ہے۔

زمانہ حال میں سب سے زیادہ پریشان کن مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ حمل کے دوران اسقاط ہو جانے کے کیس آئے دن سننے میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ موجودہ دور میں ایسے کیسوں میں بھی کوئی کمی نہیں جن میں وضع حمل کا مرحلہ بالآسانی طبعی انداز سے سرانجام پانے کی بجائے ایسی غیر طبعی صورت اختیار کر جاتا ہے کہ زچہ اور بچہ دونوں کی زندگی اور موت کا سوال پیدا ہو جاتا ہے اور کئی ایک بچوں کی پیدائش تو چیر پھاڑ یعنی آپریشن کے بغیر ہو ہی نہیں پاتی۔ اس نوعیت کے واقعات جب ایک حاملہ بار بار سنتی ہے تو قدرتی طور پر وہ انجانے خوف، دہشت اور تشویش کا شکار رہنے لگتی ہے حالانکہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر حاملہ عورت کو اس نوعیت کی

کیفیات سے دوچار ہونا پڑے، ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ حاملہ کو ذہنی طور پر پہلے سے مناسب انداز سے ان تغیرات کو خوش دلی سے برداشت کرنے کے لئے تیار کیا جائے جن سے وہ حمل کے دوران دوچار ہو سکتی ہے اور پختگی کے ساتھ اس بات کو ذہن نشین کروایا جائے کہ مذکورہ تغیرات سے پیدا ہونے والی پریشانیوں اور تفکرات پر قابو پانے میں ہی خود حاملہ کی اور آنے والے بچے کی بہتری مضمر ہے۔ دوسری صورت میں بے جا فکر و تردد یا خوف و دہشت سے خود حاملہ کو اور آنے والے بچے کو کوئی ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔

پیچیدگیاں (Complications): حمل کے جذباتی پہلوؤں میں جہاں عورت میں جذبات کی شدت ہوتی ہے وہاں اس شدت سے بعض اوقات پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ خاص کر ایسی عورتوں میں جنہوں نے بلوغت کے بعد تبدیلی کو ذہنی طور پر قبول نہ کیا ہو اور طبعی خرابیاں شروع سے موجود ہوں۔ بہت سی عورتوں کو حمل کے دوران تحفظ، محبت اور توجہ حاصل نہیں ہوتی یا وہ خاندانی معاشرتی انتشار کا شکار ہوتی ہیں اور بیماریاں طبعی حالات کے مطابق مختلف شکل میں اپنا اثر قائم کر لیتی ہیں۔ اکثر شوہر اور بیوی کے تعلقات اچھے نہ ہوں تو حاملہ نہ صرف ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہے بلکہ رد عمل کے طور پر مختلف امراض میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ جس کا اثر جنین پر بھی پڑتا ہے۔

علاج (Treatment): عورت کے جذباتی پہلوؤں کی اہمیت اور قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے اس کا شوہر بہت حد تک مددگار ہوتا ہے۔ حمل کے دوران جو تکالیف ہوتی ہیں وہ ذہنی احساسات، خوف، خوشی اور جذبات سے تعلقات رکھتی ہیں۔ اس وقت شوہر کی طرف سے مثبت انداز اور دلجوئی حاملہ کیلئے تمام تر دواؤں سے بہتر ثابت ہوتی ہے۔ شوہر کے علاوہ نرس اور ڈاکٹر حاملہ کو زچگی کے طریقہ کار سے آگاہ کرتے رہیں تو حاملہ کے ذہن کا انتشار اور خوف بہت کچھ کم ہو سکتا ہے۔ دواؤں کی صورت میں معالج ایسی بالمش ادویہ کا استعمال حاملہ کو کرائے جس سے ذہنی سکون اور وضع حمل کے قریب دردوں میں کمی رہے۔ اس کے علاوہ حفظانِ صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ زود ہضم اور متناسب غذا حاملہ کو دوسری تکالیف سے بچاتی ہے۔

مردوں کے امراض

ایک ایسی کتاب جس میں مردانہ امراض پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے اور ہر مرض کے لئے فوری اثر ہو میو پیٹھک ادویات لکھ دی گئی ہیں۔

عورتوں کے امراض

عورتوں کی مخصوص بیماریوں کے لئے لکھی گئی کتاب جس میں عورتوں کے امراض کیلئے ہو میو پیٹھک اور انگریزی علاج تحریر کر دیا گیا ہے۔

آسان علاج

عام بیماریوں کیلئے اب ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ عام امراض کیلئے ہو میو پیٹھک اور انگریزی علاج پر مبنی بہترین کتاب۔

روحانی علاج

یہ کتابچہ آجکل کی بے سکون زندگی کے مسائل کا روحانی علاج ہے۔ اس کتابچے میں مجرب اسلامی اور نورانی وظائف دیئے گئے ہیں۔

انگلش ٹینسز

اب انگلش سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ دنیا کی آسان ترین زبان ہے۔ صرف 12 روز میں انگلش ٹینسز سیکھنے کی آسان کتاب۔

انگلش سپیکنگ کورس

روزمرہ زندگی میں انگریزی بول چال کے اصول و ضوابط اور عام فہم فقرے و ضرب الامثال جو انگلش بولنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔

درج بالا کتب اردو ترجمے کے ساتھ دستیاب ہیں

پشاور ڈسٹری بیوٹرز

نامبرنگ ایجنسی: ڈسکی تحلیلی، قصہ خوانی بازار، پشاور شہر

فون: 091-2572277 / 0302-8884377 / 0307-8317755

ہتیا ڈسٹری بیوٹرز

ریڈرز پبلی کیشنز: فرسٹ فلور، 13-جان محمد روڈ، کارنر آبکاری روڈ، نیو انارکلی لاہور

فون: 042-37351898 / 0300-1177310 / 0300-4177310



Usmania Publications
1385-Krishanpura Near Bilal Town,
G.T. Road, Peshawar. Ph: 091-2262443

عثمانیہ پبلی کیشنز